

Introduction

Le poids des troubles mentaux dans la santé publique a été pendant longtemps **sous-estimé**, voire occulté. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées depuis de nombreuses années à propos d'autres maladies importantes, comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer, mais peu au sujet des maladies psychiatriques, des maladies jugées plus « honteuses »; cela est également dû à la peur que de parler d'un de ces troubles puisse l'induire. Ce n'est que récemment que les autorités politiques ont pris conscience du nombre de personnes souffrants de ces troubles, et de la gravité de ceux-ci.

Afin de mesurer l'importance d'un trouble, on a plusieurs unités, notamment les **années perdues pour cause de mort prématurée** YLL et les **années perdues pour cause d'invalidité** YLD (quasiment la moitié en Europe liées à des pathologies psychiatriques), les deux étant regroupés par le terme « DALY » (12% des DALY dans le monde sont liées à des pathologies psychiatriques; cette proportion augmente dans les pays dont le niveau de développement est élevé, p. ex. 20% en Europe). Le coût global de la maladie est également une notion importante.

Troubles	N (en millions)	Prévalence	Coût annuel (en milliards €)	Coût annuel par patient (en €)
Troubles anxieux	41	8.8 %	41	1'000
Troubles de l'humeur	21	4.5 %	106	5'048
Dépendances (OH, drogues)	9	1.9 %	57	6'333
Démences	5	1.1 %	55	11'000
Schizophrénie	3.7	0.8 %	35	9'460

On voit dans ce tableau que ce sont des troubles extrêmement fréquents!

Ce sont des pathologies qui **touchent les jeunes**; les pathologies sévères commencent en moyenne entre 20 et 30 ans! Une étude a démontré que chez les 15 - 24 ans 60% et 70% des DALYs sont dues à des pathologies psychiatriques, respectivement chez les hommes et les femmes. La prévalence de ces troubles est quasiment identique dans les différentes classes de revenu, ce qui indique une certaine limite dans l'efficacité des traitements en psychiatrie. Dans les 10 causes d'invalidité principales, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, 4 sont psychiatriques!

La **schizophrénie** en Suisse a une prévalence annuelle de 0.8% (70'000 personnes), avec une incidence de 0.02% (1'600). Le coût annuel total de la schizophrénie en Suisse peut donc être

estimé à environ 3 milliards de francs. Sachant cela, l'investissement dans ce domaine n'est largement pas suffisant; on a donc un écart majeur entre la charge représentée par les troubles mentaux et la qualité/quantité des soins qui y sont apportés.

La qualité des soins dépend du niveau de vie des pays et de certains facteurs culturels, mais même dans les pays occidentaux l'**écart entre besoins et ressources est important** (35 à 50% des patients n'ont pas reçu de traitement au cours des 12 derniers mois, contre 76 à 85% dans les pays en voie de développement).

Outre la charge directe des troubles psychiatriques, on doit considérer la forte prévalence de **comorbidités somatiques** (perception amoindrie de la douleur? moins bonne prise en charge? similitude génétique entre les mécanismes des deux pathologies?! Il faut également considérer la charge qui pèse sur les proches, et qui peut elle-même conduire à des pathologies psychiatriques ou somatiques, et à un certain degré d'invalidité.

On peut se demander pourquoi il y a si peu de volonté politique et donc de ressources financières. Notamment, il existe une **stigmatisation sociale importante**, et un manque d'intérêt du public général. De plus, on a une croyance erronée sur l'efficacité des soins, qui serait basse malgré un prix élevé. Finalement, ces maladies sont mal connues et mal défendues.

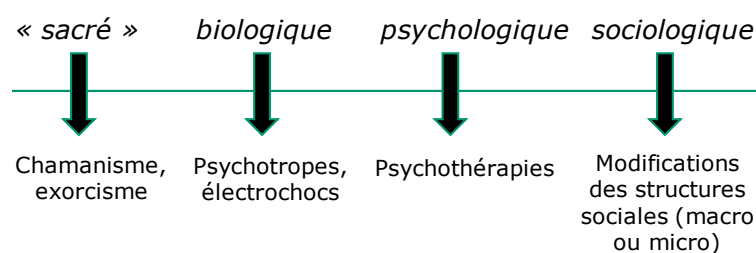
Modèles de compréhension

Introduction

Il existe des **bases** sur lesquelles les divers modèles de compréhension de la maladie mentale se sont développés. Il y a deux manières de comprendre ces troubles; soit on essaie de comprendre ce qu'est le **psychisme** sur la base d'une compréhension religieuse, philosophique ou psychologique, soit on commence par l'**observation de l'effet** de certaines substances ou approches sur la maladie (sérendipité), pour en déduire les mécanismes de certains troubles (notamment, exemple de la psychose, avec les antidopaminergiques). Au fil de l'histoire de la psychiatrie, on a souvent oscillé entre ces deux approches.

Selon le concept sur lequel on se base pour expliquer la psychiatrie, des modèles différents en découlent.

Conceptions - Modèles



Approche thérapeutique

Modèle du sacré

Le modèle du sacré renvoie à des notions de faute, de possession ou d'élection divine. Tous les textes sacrés regorgent de citations allant dans ce sens (Jeanne d'Arc); beaucoup de patients ont ce genre de modèles explicatifs, qui permettent de leur redonner du sens!

Ce modèle du sacré est **peu présent** dans les conceptions contemporaines des soignants en Occident, mais par contre cette explication est très présente chez les proches et les patients eux-mêmes, et surtout dans d'autres cultures. Dans ces cas, il est important de comprendre leur référentiel religieux et culturel. Une partie de la stigmatisation des troubles mentaux est liée à ce **sentiment de punition** d'un péché vis-à-vis d'une autorité divine!

Modèle biologique

Il est venu après le modèle psychologique, et a donc été une réaction violente à une approche trop psychologique des troubles mentaux. Dans cette théorie « brute », toutes les manifestations du psychisme peuvent être réduites à la physiologie du SNC; les pathologies psychiatriques sont donc liées à des **dysfonctionnement du cerveau**, et la psychologie n'a rien à voir là-dedans. Pour poser un diagnostic, il suffit d'identifier ces mécanismes.

Jusqu'à preuve du contraire, le psychisme a tout de même un rôle à jouer! Mais on remarque aujourd'hui que le modèle biologique est très en vogue, notamment car le journal de référence en psychiatrie est « molecular psychiatry »; on est peut-être à l'orée d'une nouvelle ère, mais pour l'instant on n'a pas obtenu de résultats vraiment utiles aux patients.

Il y a souvent un problème au niveau des patients, qui ne se sentent pas réellement pris en charge lorsque l'on traite le biologique uniquement. Le dialogue entre psychologie et biologie est donc nécessaire dans les approches contemporaines.

Modèle sociologique

Dans sa forme dure, cette théorie affirme que ce sont les **conditions sociales qui définissent la déviance**, ou qui conduisent l'individu à la déviance; les fous seraient les sages d'une société malade.

De nombreuses enquêtes épidémiologiques ont démontré le rôle de facteurs sociaux comme co-déterminants des troubles mentaux, donc on ne peut pas nier que le facteur sociologique joue un rôle important. Certaines pathologies ont des prévalences très différentes d'une culture à l'autre, ou émergent dans des conditions sociologiques données. De plus, il ne faut pas nier l'importance des aspects culturels de stigmatisation des maladies mentales.

Modèle psychologique

C'est le socle des approches de psychothérapie. Dans sa forme dure, le biologique est perçu comme un élément statique, figé, freinant les possibles évolutions, et le psychologique est une tentative d'y intégrer des connaissances en suivant certains modèles.

Officiellement, il y a 3 formes principales de modèles psychologiques, qui sont soutenus par trois modèles de compréhension.

Psychanalytique

Freud a développé cet axe, en parlant de l'inconscient et en développant une compréhension de notre psychisme. Ce modèle se réfère à la fois à une conception du psychisme humain et à un modèle de soins, qui doit favoriser l'accès à l'inconscient du patient.

Au fond, il y a **trois instances**, le ça (siège de l'inné et des pulsions), le moi (siège de la décision, fait le juge entre les deux instances) et le surmoi (siège de l'acquis et des interdits). La première compréhension des pulsions de Freud étaient les sexuelles, mais vers la fin il a ajouté à ces pulsion de vie des pulsions de mort.

Les pulsions qui émanent du soi, la pression de contrôle du surmoi et la nécessité de décision du moi créent des conflits internes, et on a des outils qui permettent de gérer cette tension.

On appelle cela les **mécanismes de défense** qui garantissent l'équilibre du moi: humour, refoulement, dénégation, intellectualisation, projection. Selon l'intensité du stress, on a recours à des mécanismes de plus en plus archaïques.

Cognitivo-comportementaliste

Ce mouvement est né de psychiatres et psychothérapeutes qui étaient frustrés de cette approche psychanalytique, où l'on comprend très bien ce qu'il se passe sans parfois pouvoir changer quelque chose et influencer sur la vie du patient. Cette approche consiste donc à aider les gens, en observant leur comportement en surface.

Pavlov a été un des pionniers. Ce modèle se développe à partir des travaux sur le conditionnement, qui visent essentiellement des comportements. On postule l'existence de schémas de pensée pour traiter l'information, qui se renforcent progressivement au cours de la vie.

On peut citer la thérapie cognitive, qui cible les modifications pathologiques du traitement de l'information, et la thérapie comportementale, qui consiste en un désapprentissage de symptômes et de comportements pathologiques. Le modèle TCC, quant à lui, est une approche qui se base sur ces deux aspects.

Systémique

Cela a aussi été inventé par des psychanalytiques qui ne parvenaient pas à changer quelque chose à la vie du patient, car il est toujours traité de la même manière par son entourage.

Il s'agit donc de rééquilibrer le système entier, car on a réalisé l'importance de prendre en compte les influences extérieures dans la prise en charge. On agit sur les rapports de forces entre tous les éléments du système; cela s'applique non seulement à la famille, mais aux différents réseaux dans lequel le patient est inséré. Cela permet à ces différents acteurs d'adopter tous la même attitude pour que le patient puisse répondre à ces attentes.

Modèle bio-psycho-social

Aujourd'hui, chacune de ces conceptions a ses défenseurs « durs », qui sont heureusement de plus en plus rares, et qui pensent que leur modèle est le seul valable et rejettent les autres. Cependant, un consensus de plus en plus large se forme autour de l'idée que les modèles biologique, psychologique et sociologique sont complémentaires; c'est le **modèle bio-psycho-social**. Le sacré a été pratiquement exclu de ce modèle dans les pays développés.

Selon la conception que l'on a de la maladie mentale, les modèles et les approches thérapeutiques varient. Le poids respectif attribué à chaque de ces 3 éléments varie bien entendu d'un thérapeute à l'autre, et peut être soumis à des pressions idéologiques ou économiques. Dans une prise en charge thérapeutique, il faut aussi être attentif au modèle, implicite ou explicite, qu'a le patient, ou sa famille, de l'origine des troubles.

Dans la pratique, on n'hésite pas à combiner ces modèles, pour tenter d'obtenir une efficacité thérapeutique optimale.

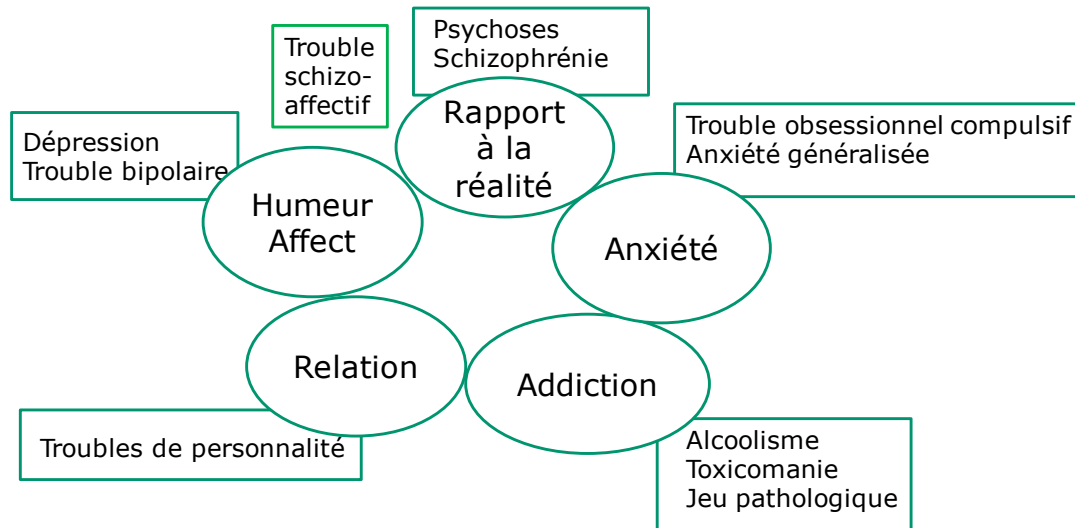
Principaux syndromes psychiatriques

Introduction

En médecine somatique, on fait la distinction entre signes et symptômes; en psychiatrie, cette **distinction est beaucoup plus floue**. En effet, on ne peut pas observer la vie psychique d'un individu comme on observe un objet (par de réel status psychiatrique). La sémiologie va donc toujours apparaître dans le cadre d'une **relation interpersonnelle** (art de créer un contexte propice pour retirer des informations utiles). De plus, on doit également prendre en compte ses propres réactions (contre-transfert) pour construire le diagnostic.

Pour de nombreux traits de la vie psychique, la **limite entre ce qui est normal et ce qui est pathologique n'est pas claire** (réelle pathologie ou société trop rigide?); il est difficile de fixer un seuil quantitatif normal pour les émotions (le psychiatre ne doit pas avoir une attitude normative de l'individu).

Le caractère pathologique d'une manifestation pourra être déterminé par le contexte relationnel et culturel dans lequel cette manifestation apparaît, la souffrance que cette manifestation induit chez le patient et ses proches, ainsi que son apparition au sein d'un ensemble syndromique de manifestations.



La classification se fait par le système **AMDP** (Association for Methodology and Documentation in Psychiatry), qui est un système allemand traduit en plusieurs langues, un manuel décrivant de manière détaillée les symptômes.

Signes et symptômes

Les symptômes ne sont pas propres à un seul diagnostic. Par exemple, la dépression peut se voir dans les troubles dépressifs mais aussi dans les troubles bipolaires ou dans la schizophrénie, et les symptômes psychotiques se voient dans la schizophrénie, mais également dans les troubles bipolaires ou organiques.

Trouble de l'humeur

On a deux versants aux troubles de l'humeur. La **phase maniaque** est une phase de sur-excitation psychique, avec une sensation de n'avoir plus de limites, de pouvoir tout accomplir, de vouloir tout réaliser en même temps. Le patient est comme dans un état second, et il est difficile de le confronter avec la réalité.

Dans ces aspects plus exubérants que la norme, on a d'autres étapes plus précoces et moins extrême que cette euphorie, qui sont la dysphorie (mauvaise humeur), l'irritabilité, l'agitation intérieure et une labilité affective (changement rapide de l'humeur).

De l'autre côté, en comparaison, la **phase dépressive** est une véritable descente aux enfers. Ce changement entre les deux phases peut se faire très rapidement (risque suicidaire élevé), ou de

manière plus progressive. On a également un sentiment important de solitude et d'isolement, avec des problèmes de mémoire et de concentration.

Sur le **pôle dépression**, on peut également parler d'humeur déprimée, qui est le sentiment d'une certaine tristesse, mais avec un patient toujours fonctionnel. Puis, on peut avoir une perte d'espoir, un sentiment d'insuffisance, voire même de culpabilité et de ruine (sentiment de poids sur son entourage).

Rapport à la réalité

Troubles psychotiques

On sépare cela en **4 chapitres**: le délire, les troubles de perception (illusions, puis hallucination), les troubles du moi et les troubles formels du cours de la pensée.

Troubles schizo-affectifs

On a un mélange de dimensions affectives, avec la dépression ou la manie, et psychotiques, avec les 4 éléments cités ci-dessus.

Troubles anxieux

Tout d'abord, on peut avoir une **méfiance non-délirante**, ce qui se traduit par une attitude soupçonneuse, tantôt anxieuse, tantôt hostile, avec un entourage perçu comme malveillant. Ensuite, on a les **phobies**, qui sont les peur de certaines situations ou objets, qui mènent à des conduites d'évitement.

Puis, les obsessions sont les idées et les représentations qui s'imposent de manière répétée et sont vécues comme absurdes. Finalement, les compulsions sont des conduites que le sujet accomplit toujours sous la force de contraintes intérieures obsédantes, même en sachant qu'il ne doit pas le faire.

Trouble de la personnalité

Ces personnes ont une tendance à l'agir, à l'impulsivité. On constate des actes hétéro- et auto-agressifs, ainsi que souvent des abus de substances et des dépendances.

Nosologie

La nosologie est une branche de la médecine qui étudie les critères de classification des maladies. C'est principalement sur la base de la présence de tel ou tel de ces symptômes que se construit le diagnostic psychiatrique selon les classifications DSM ou CIM. Le diagnostic peut cependant aussi se voir sous d'autres angles selon l'approche.

Ces classifications sont utiles, car sans précision et consensus dans la définition des pathologies mentales, des problèmes majeurs se posent à la recherche, qu'elle soit épidémiologique, clinique et étiologique.

Le **DSM** classe des troubles, et non pas des maladies. Il faut cela dans une approche catégorielle, qui se veut indépendante de toute conception théorique, et qui est multiaxial. Il élabore des critères pour chaque catégorie diagnostique, visant à favoriser la fiabilité du diagnostic. Ces différents manuels ne sont pas des manuels de psychiatrie.

La classification que l'on utilise actuellement est la **CIM-10**, éditée par l'OMS. L'élaboration des DMS-III et IV a influencé la rédaction du chapitre de cette Classification Internationale des Maladies, consacrée à la psychiatrie. Cette révision de cette classification reprend ainsi la notion de trouble, et l'élaboration des critères. Elle n'a pas adopté le système multiaxial.

Troubles de l'humeur

Episodes thymiques

Episode dépressif

L'épisode dépressif est caractérisé par des symptômes psychiques et somatiques, mais c'est quasiment uniquement ces derniers qui sont décrits par les patients; le patient ne sait pas qu'il est déprimé.

Il faut donc rechercher activement les **symptômes psychiques**, qui sont caractérisés par une humeur dépressive, un pessimisme, une auto-dévalorisation, une culpabilité et une indignité, une anhédonie (incapacité à éprouver du plaisir) et des idées suicidaires. L'**humeur dépressive**, au cœur de la dépression, ne doit pas être confondue avec la tristesse, qui est une émotion normale qui fait sens. L'humeur dépressive, elle est désagréable, définie par un vide, une pesanteur, une lenteur, une difficulté à faire des choses et une fatigue psychique.

Les **symptômes psychomoteur** sont de la fatigue, ainsi qu'un ralentissement ou une agitation, qui sont définies par une perte de l'élan vital, une bradypschie, une bradyphémie, une aboulie (absence de volonté) et un faciès figé.

Les autres symptômes sont des troubles de la concentration et de la mémoire, une insomnie et une hypersomnie, ainsi que de l'anorexie et des pertes de poids ou une prise de poids. On constate également une diminution de la libido, des alcoolisations, des douleurs fonctionnelles, une constipation ainsi que des troubles cognitifs (personne âgée).

L'épisode dépressif majeur est défini par **cinq des symptômes** suivant pendant au moins deux semaines:

1. Humeur dépressive
2. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée
3. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir
4. Idées suicidaires récurrentes
5. Fatigue ou perte d'énergie
6. Agitation ou ralentissement psychomoteur
7. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision
8. Insomnie ou hypersomnie
9. Perte ou gain de poids significatifs

La présentation clinique n'est pas la même chez les hommes que chez les femmes; ces dernières ont plus de ressources pour exprimer la douleur morale. L'homme exprime plus d'agitation et d'irritabilité, et se réfugie plus facilement dans le travail ou les conduits addictives; de plus, ils ont aussi plus fréquemment des épisodes de colère.

Episode maniaque

Les **symptômes psychiques** consistent en une humeur exaltée, euphorique, expansive, et en une labilité et versatilité émotionnelle (joie, irritabilité, agressivité). Ces patients ont un contact hypersyntone, c'est-à-dire qu'ils ont une plus grande communicabilité. De plus, on constate des idées de grandeur à propos de sa propre personne.

Comme ces patients sont dans un état de bien-être total, ils ne se considèrent absolument pas comme maniaque, et il est très difficile de les raisonner.

Au niveau des **symptômes psychomoteurs**, on a l'impression que des pensées se bousculent dans la tête du patient, et qu'il n'y même plus le temps de mettre correctement des mots dessus (logorrhée). Les phrases n'ont plus aucun sens, et le patient est confus (difficile à nommer, car on est entraîné depuis toujours à corriger les erreurs dans les conversations). On constate également des jeux de mot sur les sons sans sens particulier.

En plus de cette activation psychique, on a également une activation motrice, qui est caractérisée par une tachykinésie, une hypermimie ainsi qu'une désinhibition instinctivo-comportementale.

On a également d'autres symptômes, comme la désinhibition sociale et l'hypersexualité, la réduction du besoin de sommeil et l'insomnie, ainsi que l'anorexie et la perte de poids (ou prise de poids).

L'épisode maniaque est défini comme une période nettement délimitée, et d'au moins une semaine, durant laquelle l'humeur est anormalement élevée ou irritable. Il doit y avoir au moins 3 des symptômes suivants:

1. Augmentation de l'estime de soi ou idée de grandeur
2. Plus grande communicabilité et désir de parler constamment
3. Fuite des idées
4. Distractibilité
5. Réduction du besoin de sommeil
6. Engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables (financières, sexuelles, etc.)
7. Augmentation de l'activité orientée vers un but (social, scolaire, sexuel) ou agitation psychomotrice

A l'**anamnèse** spontanée, on a donc souvent **peu d'informations** donnée par le patient, car on a un déni de la maladie. L'anamnèse dirigée est centrée sur les comportements, le rythme veille-sommeil, les dépenses, le comportement social ainsi que les projets professionnels. L'hétéro-anamnèse, qu'elle soit indirecte (« Vous a-t-on fait des remarques sur...? ») ou directe, peut être très utile.

Episode hypomaniaque

Les symptômes sont identiques à l'épisode maniaque, et ils durent au moins 4 jours. L'intensité est cependant moindre, car on n'a pas d'altération marquée du fonctionnement social et professionnel, **jamais d'idées délirantes** et l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Elle prend plutôt la forme d'une amélioration de l'efficacité, des réalisations ou de la créativité.

Hypomanie	Manie
Légère, moins grave	Grave
Altération du fonctionnement faible à modérée	Altération marquée du fonctionnement
Erreurs de jugement moindres/limitées	Erreurs de jugement importante
Répond fréquemment au traitement ambulatoire	Nécessite souvent une hospitalisation
Régulation du sommeil et/ou emploi de benzodiazépines	Traitement aigu par un thymorégulateur et/ou un antipsychotique.

Episode mixte

Ces épisodes sont beaucoup plus fréquents que ce que l'on croyait, de 70% environ. Cependant, ils nécessitent une observation assez rapprochée pour poser un diagnostic.

Les critères doivent être réunis à la fois pour un épisode maniaque et pour un épisode dépressif majeur (à l'exception de la durée), et cela presque tous les jours pendant au moins une semaine. La perturbation de l'humeur est suffisamment sévère pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel, des activités sociales ou des relations interpersonnelles, ou pour nécessiter l'hospitalisation afin de prévenir des conséquences dommageables pour le sujet ou pour autrui, ou il existe des caractéristique psychotique.

Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une autre affection médicale générale.

Dépressions

Nosologie des troubles dépressifs

Troubles dépressifs majeurs

Lorsque l'on a un épisode isolé, on quantifie la sévérité (léger 5-6, moyen 7-8, grave 9); ce n'est pas une échelle diagnostique! On a des **caractéristiques psychotiques**, donc des idées délirantes, éventuellement des hallucinations, et des thématiques comme la culpabilité délirante, la punition méritée, la ruine, le nihilisme de soi et du monde, le pourrissement du corps, les voix hostiles, accusatrices.

La dépression est chronique (15-30%) à partir de 2 ans. On peut également avoir une dépression majeure récurrente, qui a une évolution longitudinale (rémission, dysthymie), et éventuelle un caractère saisonnier. Les symptômes de cette **forme saisonnière** (à l'automne), qui touche plus les femmes jeunes, sont une baisse de l'élan vital, un appétit exagéré et une hypersomnie. La luminothérapie fonctionne sur ce type de dépression, et est remboursée par les caisses.

Cet épisode peut avoir 4 formes: catatonique, post-partum, mélancolique et atypique. La **catatonie** consiste en une immobilité motrice avec catalepsie (flexibilité cireuse), un négativisme, un mutisme, des stéréotypies gestuelles, ainsi que des écholalies et échopraxies. Ce tableau est relativement rare.

10% des femmes connaissent un état dépressif majeur dans les mois qui **suivent une naissance**, et 50% ont encore des symptômes dépressifs après 6 mois; 30% des femmes rechutent. Les facteurs de risque spécifiques sont une anamnèse de dépressions antérieurs, une relation conjugale conflictuelle, un manque de soutien social, et un environnement stressant. Il ne faut pas confondre avec un baby blues, qui dure 2-3 semaines après l'accouchement.

La **forme mélancolique** est difficile à diagnostiquer, et c'est la forme la plus grave. Elle est caractérisée par une douleur morale particulièrement intense, et le risque suicidaire est élevé. On a plusieurs formes cliniques: stuporeuse, agitée, délirante.

Dans la **forme atypique**, le patient a une réactivité de l'humeur, et est sensible au rejet. Les symptômes s'aggravent le soir, l'appétit est exagéré (fringale sucrée) et la libido augmentée. On a une insomnie d'endormissement et une hypersomnie, ainsi qu'une réponse favorable aux IMAO.

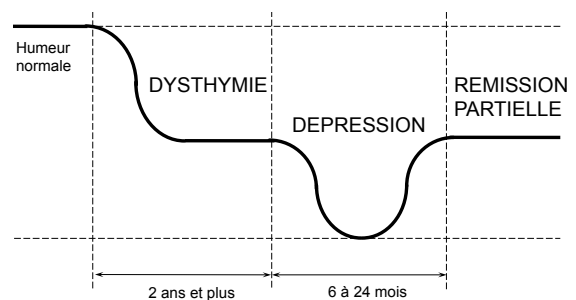
La durée d'un épisode est variable, de quelques semaines à plusieurs mois sans traitement; on 60-70% de rémission totale si le traitement est adéquat. La moitié des dépressifs majeurs récidives, et plus on a d'épisodes, plus on a de risque de rechute (50%, 70%, 80% puis 85%). Les formes récurrente présentent une fréquence variable, et la rémission est totale ou partielle entre les épisodes.

Dysthymie

Le trouble dysthymique est une **dépression chronique à bas bruit**. Il est caractérisé par une humeur dépressif, qui est présente pratiquement toute la journée, plus d'un jour sur deux, pendant au moins deux ans. On constate la présence d'au moins deux des symptômes suivants:

1. perte d'appétit ou hyperphagie
2. insomnie ou hypersomnie
3. baisse d'énergie ou fatigue
4. faible estime de soi
5. difficultés de concentration ou difficultés à prendre des décisions
6. sentiments de perte d'espoir

40% des patients développent un trouble uni- ou bipolaire, et la mortalité par suicide de cette pathologie est de 3-12%. Les hospitalisations sont fréquentes, et on a une évolution sociale défavorable dans 60% des cas. On a une chronicité pour 80% des patients, avec 15-30% de dépression majeure. On appelle une **dépression double** une dysthymie qui s'aggrave d'un syndrome dépressif majeur.



Trouble de l'adaptation

Il est caractérisé par la mise en évidence de symptômes dépressifs liés à un événement particulier dans les 3 mois précédents, qui vont au-delà d'une réaction normale.

C'est un diagnostic que l'on doit utiliser avec précaution et discernement. En effet, même s'il a un lien avec un événement, il n'est pas moins grave que la dépression majeure, car on a le même risque au niveau des abus de substances, du suicide, et le même temps de traitement. 25% des patients ne sont pas améliorés à 3 ans.

Diagnostic

Il existe évidemment un certain nombre de maladies somatiques qui s'expriment par des troubles dépressifs. Mais de manière générale, ce ne sont pas ces aspects somatiques qui ne sont pas bien investigués, mais plutôt la dépression elle-même.

Epidémiologie

La dépression apparaît plutôt chez les jeunes, avec un âge moyen du premier épisode entre 30 et 35 ans; bien entendu, le début reste possible à tout âge. Il est deux fois plus fréquent chez la femme à partir de l'adolescence.

La prévalence sur la vie entière de la dépression majeure est de 20% chez les femmes et de 10% chez les hommes; sur une année, 10% des femmes et 5% des hommes sont touchés. Finalement, il y a 1% de troubles bipolaires sur la vie entière.

Le trouble bipolaire est la maladie dont la vulnérabilité à l'**hérédité** est la plus forte, suivie par la schizophrénie puis la dépression majeure isolée.

Les autres facteurs de risque sont le sexe, le postpartum, les problèmes somatiques, la personnalité, le niveau de formation, le contexte social et les événements de vie.

Evolution et complications

Au niveau des complications qu'entraîne la dépression, on peut tout d'abord avoir des **conséquences familiales, sociales et professionnelles**, qui se traduisent par des problèmes relationnels et une incapacité de travail (rente AI).

Les **conséquences médicales** sont tout d'abord les **effets secondaires des médicaments**, comme de l'agitation, des troubles de l'appétit, des problèmes digestifs et une baisse de la libido. On a également une problématique de la qualité de la prise en charge, notamment avec des généralistes qui donnent uniquement des anti-dépresseurs dont l'efficacité est discutée.

Ensuite, toujours dans les conséquences médicales, on peut avoir des **problèmes somatiques**; le symptôme principalement mis en avant est la **douleur**, que l'on peut faussement diagnostiquer de troubles somatophores pour lesquelles l'AI ne donne plus de rente. Il faut être particulièrement attentif, car les patients n'ont pas les ressources pour identifier leur atteinte comme un état dépressif.

On constate une forte comorbidité entre les maladies cardiovasculaires et les dépressions, donc il faut investiguer cet aspect chez les patients post-infarctus. On a également une corrélation avec les maladies neurologiques dégénératives, ainsi que les maladies métaboliques.

Chez 90% des **suicidés**, on a ce que l'on appelle des autopsies psychiatriques, avec 50% de dépressions, 35% de trouble de la personnalité, 30% d'alcoolisme et 6% de schizophrénie. C'est donc une faute de ne pas investiguer les idées suicidaires chez les patients déprimés; de plus, aborder le sujet n'induit pas d'idées suicidaires, contrairement à l'idée reçue.

Étiopathogénie

Actuellement, on n'a **aucun modèle explicatif plausible** pour expliquer la dépression. On connaît certains facteurs psychologiques, sociaux, de la petite enfance, biologique, mais aucun réellement strict.

Pour ce qui est du biologique, on sait que certaines anomalies fonctionnelles ou structurelles sont associées à la dépression. Les différents modèles biologiques sont aujourd'hui passés de mode; on peut citer les amines biogènes, l'axe endocrinien, ainsi que le rythme du sommeil. La localisation des récepteurs 5-HT1A largement répandue illustre le peu de spécificité des neurotransmetteurs.

Les modèles psychologiques sont valides, mais ne représentent qu'un zoom sur un des paramètres de la dépression. On peut citer plusieurs modèles, notamment l'agressivité retournée contre soi, la rupture d'un lien affectif, l'estime de soi insuffisante, ainsi que les schèmes cognitifs négatifs (abstraction sélective, inférences arbitraires, surgénéralisation). Il existe donc de nombreux modèles, sans idée actuelle pour les simplifier.

Les facteurs protecteurs sont d'avoir un conjoint et des enfants; cela est probablement lié à la quantité d'interactions sociales.

Traitement

Les aspects généraux du traitement sont une coopération entre le patient et le médecin. Il faut proposer un **cadre à la relation** (nécessite de prendre du temps), et faire des entretiens de couple et de famille. En principe, on ne propose pas d'antidépresseurs après un seul entretien!

Les patients doivent savoir que la dépression est une **maladie qui se soigne** (70% de rémission avec traitement), avec des traitements généralement efficaces, et qu'ils ont plusieurs options thérapeutiques. Ils doivent connaître l'objectif du traitement, qui est la rémission complète des symptômes, ainsi que les symptômes, l'évolution et les signes de rechute.

Les modalités de traitement sont la médication, la psychothérapie, les combinaisons médication-psychothérapie, la luminothérapie, l'hospitalisation et l'électro-compulsivo-thérapie ECT, qui est utilisée uniquement dans le cadre des dépressions sévères récalcitrantes au traitement avec un pronostic sévère.

75% des patients préfèrent la **psychothérapie** à la pharmacothérapie. Cependant, cette opposition est fautive, car les deux sont des dimensions différentes d'un même soin. On peut prédire la réponse à une thérapie en fonction de l'insula. Le médicament consiste en un effet de l'amygdale sur le cortex, tandis que c'est l'inverse pour la psychothérapie; les deux méthodes ont cependant un résultat semblable. Les deux ont une efficacité et une vitesse d'action analogues pour les dépressions modérées, et on a des mécanismes d'action au niveau cérébral qui sont communs et spécifiques aux deux méthodes.

La psychothérapie reste efficace dans toutes les formes de dépression, elle a moins d'effet secondaire, moins de rupture de traitement, et elle a des effets à long terme notamment de prévention des rechutes.

L'indication à l'**hospitalisation** est une suicidalité incontrôlable, un épisode dépressif sévère avec inhibition ou agitation marqués, une insomnie sévère et persistante, une angoisse aiguë et des attaques de panique envahissantes, des problèmes psychosociaux (isolement, âge, surmenage, entourage peu soutenant), une dépression réfractaire, ainsi qu'une manie avec des risques de passages à l'acte.

Le **traitement combiné** est recommandé d'emblée en cas de dysthymie, de dépression chronique, de traits de caractère et de troubles de la personnalité, de symptômes résiduels (après un traitement avec une des deux modalités), de risque de rechute, d'alliance et d'adhérence au traitement, d'acquisition de stratégies de résolution de problèmes ainsi que de problèmes relationnels avec l'entourage.

Les avantages du traitement combiné sont moins de refus de traitement, une meilleure compliance médicamenteuse, ainsi qu'un taux de réponse et un taux de rémission supérieurs.

Diagnostic	Traitement
EDM léger à moyen	Psychothérapie spécifique (Antidépresseurs)
EDM récurrent	Traitement de continuation
EDM avec symptômes psychotiques et mélancolie	Antidépresseurs et neuroleptiques ECT
Dépressions atypiques	Antidépresseurs non tricycliques
Dépressions saisonnières	Luminothérapie
Troubles dysthymiques	Psychothérapies Antidépresseurs Traitement combiné
Dépressions chroniques ou complexes	Traitement combiné

Les **avantages** de la **prise en charge par le généraliste** sont qu'il est disponible à court terme, que la relation de confiance est déjà établie, que la prise en charge est globale, qu'il n'y a pas de stigmatisation psychiatrique, que l'on a un contact avec la famille et l'entourage, que le traitement peut être débuté précocement et que l'on a un suivi à long terme.

Il y a **plusieurs écueils** possibles de la prise en charge par le généraliste, qui sont un diagnostic parfois difficile (comorbidités, troubles de la personnalité), un évitement de la confrontation au diagnostic psychiatrique, une interprétation psychologisante, une disponibilité limitée pour un casier de type psychothérapiques (fréquence et durée des entretiens), des stratégies pharmacologiques limitées, ainsi qu'une absence de formation aux psychothérapies spécifiques.

Le médecin généraliste doit savoir **transmettre au psychiatre** lorsque le diagnostic est incertain, lorsque la dépression est accompagnée de symptômes psychotiques, bipolaire, chronique, en cas de troubles dysthymiques, de comorbidités, de suicidalité, de résistance au traitement prescrit à 4-6 semaines, d'intolérance aux effets secondaires ainsi que d'utilité d'une psychothérapie spécifique.

Troubles bipolaires

Types

Historiquement, on a déjà chez Kraepelin en 1899 une description de ce qu'il appelle la psychose maniaco-dépressive, une succession d'accès maniaques et dépressifs, accompagné d'anosognosie, particulièrement en phase maniaque; ce symptôme complique évidemment la prise en charge. De plus, le patient a une meilleure mémoire des phases dépressives. On constate également des idées délirantes, ainsi que des hallucinations.

Le **trouble bipolaire de type 1** est diagnostiqué dès que l'on a au moins un épisode maniaque franc; on a pas besoin d'épisode dépressif pour ce diagnostic. C'est logique, car c'est particulièrement la phase maniaque qui est destructive pour le patient et son environnement!

Pour le **trouble bipolaire de type 2**, il faut au moins un épisode dépressif, et une hypomanie. Le pronostic est moins grave, car un mauvais pronostic est lié à l'état maniaque.

Les **cycles rapides** sont caractérisés par au moins 4 épisodes thymiques par année, avec au moins un épisode maniaque; le cycle est, comme son nom l'indique, rapide. Il ne faut pas maintenir le traitement antidépresseur dans ces cas après résolution de la dépression, car cela accélère les cycles!

On parle de **cyclothymie** lorsque l'on a des successions de dépression mineure et d'épisode hypomaniaque.

On a tendance à ne plus voir ces distinctions comme des distinctions catégorielles, mais plutôt comme des repères. Il y a un continuum entre ces différentes formes, et on a donc tendance à parler de spectre de troubles bipolaires, car on peut voir toutes sortes de conformations! La vulnérabilité serait la même pour tous ces patients, mais l'expression différentielle serait due aux ressources du patient.

Diagnostic

L'épisode maniaque a un début typiquement brutal avec une aggravation rapide. L'intensité est variable, et on a le plus souvent des formes sévères avec des idées délirantes ou des hallucinations, qui sont plus ou moins congruentes à l'humeur.

Les épisodes maniaques sont compliqués par des toxiques, comme l'abus d'alcool ou de drogues, qui aggravent et prolongent l'épisode. Beaucoup de toxicomanes sont bipolaires; c'est important à mettre en évidence, car la **toxicomanie** ne peut pas être traitée si le trouble ne l'est pas. Lorsqu'on le traite bien, il y a 80% de rémission totale; en revanche, sans traitement, on constate 90% de récives.

La **durée de l'épisode est variable**, de 4 semaines à plusieurs mois; la fréquence des cycles est également variable, avec une rémission totale ou partielle entre les épisodes. C'est une maladie très handicapante, car le patient bipolaire passe la moitié de son temps symptomatique. La moitié de ces patients ne travaillent pas, et on a 8-10% de suicide.

Le trouble bipolaire est un **diagnostic difficile**, car il y a peu de mémoire à l'état maniaque, car le patient se sent bien. On a 69% d'erreurs diagnostics: dépression (60%, on manque les troubles maniaques), troubles anxieux, schizophrénie, trouble de la personnalité limite ou antisociale, abus d'alcool ou de substance. Le 35% des patients ont attendu 10 ans ou plus avant de recevoir un diagnostic correct!!

On peut suspecter l'apparition d'un trouble bipolaire avec des **dépressions débutant avant 20 ans**, accompagnées de symptômes psychotiques, d'antécédents familiaux de trouble bipolaire, d'une hypomanie induite par un médicament, d'une anxiété épisodique, d'une irritabilité, d'une dépression chronique et d'un ralentissement psychomoteur.

Le **diagnostic différentiel avec la schizophrénie** n'est pas facile, et est du ressort du spécialiste. La différence entre l'anhédonie et l'athymormie (vide affectif) n'est pas facile, comme la fuite des idées et les troubles du cours de la pensée. De plus, dans les deux cas, on a des délires de persécution, des hallucinations, des cycles rapides, des états mixtes et un retard mental.

Epidémiologie

Pour le type 1, on a 1% de prévalence dans la population générale, avec une répartition homme/femme équivalente. Pour le type 2, les épidémiologies divergent plus, mais on peut considérer une prévalence de 2-3%. **50% des patients déprimés** le sont dans le cadre d'un trouble bipolaire!

Le début est possible à tout âge, mais habituellement autour de 20 ans (50% avant). Le type du premier épisode est variable, et le **retard diagnostique entre 10 et 15 ans**.

Principes généraux du traitement

On doit premièrement **traiter les phases aiguës**, donc les épisodes dépressifs majeurs et les états maniaque. Il existe tout d'abord beaucoup de molécules efficaces pour traiter les épisodes dépressifs, et pas que des anti-dépresseurs; l'effet placebo est très important, donc il est nécessaire de bien expliquer au patient les effets attendus.

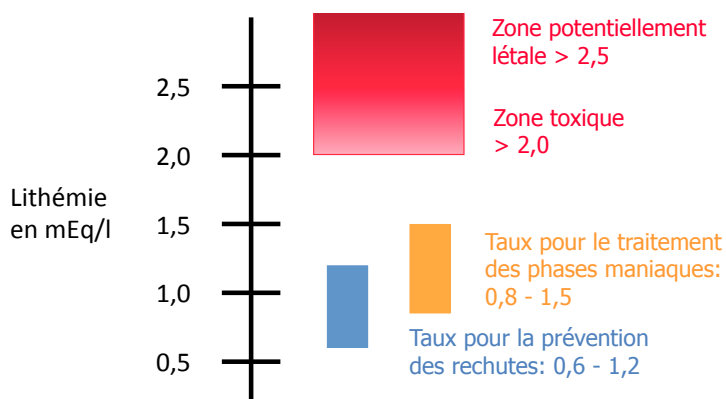
Il faut être attentif, car il y a un **risque de virage maniaque** avec ces traitements (23% placebo, 20% lithium, 51% tricyclique). 25% des patients voient leur cycle accélère à cause du traitement antidépresseur, notamment chez les femmes jeunes! Les inhibiteurs de recapture de la sérotonine ISRS sont les antidépresseurs de choix chez les patients avec un trouble bipolaire, car ils ont une meilleure tolérance, une meilleure compliance, un risque de virage diminué; il faut cependant faire attention aux interactions médicamenteuses.

A ceux-ci, on ajoute un thymorégulateur, comme le lithium, la lamotrigine ou l'acide valproïque. On peut également donner des benzodiazépine à haute dose afin de calmer le patient.

Ensuite, on a également la facette de l'hospitalisation d'office, qui est presque toujours nécessaire, surtout dans les premiers épisodes maniaques au moins. Puis, on donne un **traitement prophylactique au long court** pour empêcher les rechutes. Ce sont des médicaments stabilisateurs de l'humeur.

Le **lithium** est dans ce contexte un médicament très efficace; sa fenêtre thérapeutique est étroite, et donc on doit faire une titration régulière au début de son administration, puis un dosage tous les 3 mois chez un patient compliant. Un bilan (électrolytique, cardiaque, rénal, thyroïdien) est nécessaire avec cette

prescription, et devient annuel ensuite. Il faut être prudent en cas de grossesse, d'utilisation de diurétique, de régime sans sel, de déshydratation et de fièvre.



Combiner troubles bipolaires et **grossesse** est de l'apanage du spécialiste, qui travaille en équipe avec l'obstétricien. Le problème est que les médicaments ont un risque tératogène, notamment l'acide valproïque qui est à éviter formellement, et le lithium, la carbamazépine et la paroxétine qui sont contraindiqués. Il faut mettre l'utilisation de médicaments en balance avec les effets délétères à court et moyen terme d'un épisode aigu pendant la grossesse.

Finalement, ce traitement a également des **aspects non-pharmacologiques**, que l'on appelle psycho-éducation. En première ligne, on sensibilise le patient à sa maladie, afin qu'il puisse détecter précocement les syndromes prodromaux, qu'il adhère au traitement, et que cela prévienne les rechutes et les suicides.

Ensuite, en deuxième ligne on apprend la gestion du stress, à éviter les abus d'alcool et de drogue, et on favorise un style de vie plus normal. Finalement, en troisième ligne, on améliore la deuxième ligne, on aide à faire face aux conséquences des épisodes passés et futurs, on améliore le fonctionnement entre ces épisodes, on fait face aux symptômes résiduels qui perturbent le fonctionnement, et on améliore la qualité de vie et le bien-être.

Troubles anxieux

Introduction

L'**anxiété non pathologique** est une souffrance faible et **supportable**, et on garde un sentiment de contrôle du vécu psychopathologique; on a la capacité de mettre de côté les symptômes temporairement, et son interférence avec la vie quotidienne est minime. Cette émotion normale est liée à un événement que l'on peut considérer comme angoissant pour la majorité des sujets, on a **peu de symptômes physiques** et une durée limitée.

La dépression et l'anxiété ont des symptômes communs, comme la fatigue, le manque d'énergie, un élan vital diminué, des troubles de concentration, du sommeil et de l'appétit, des plaintes somatiques cardiovasculaires ou digestives, une irritabilité et une idéation suicidaire.

Dépression	Anxiété
Humeur dépressive (perte réalisée de quelque chose d'essentiel)	Anticipation anxieuse (crainte d'un malheur)
Ralentissement psychomoteur (car vie n'a plus de sens)	Inhibition (frein; peur de provoquer la catastrophe crainte)
Anhédonie (repli sur soi)	Comportement d'évitement
Sentiment de désespoir	Dépersonnalisation et déréalisation
Douleurs chroniques	Troubles neurovégétatifs (panique)

Il peut y avoir une **relation entre les symptômes anxieux et dépressifs**; le trouble anxio-dépressif est cependant un diagnostic discutable (pas de vraie maladie qui se traduit par ça). Il faut faire un choix entre les deux diagnostics, afin d'avoir une stratégie de prise en charge claire et qui puisse aider le patient. L'anxiété peut être une composante importante de la dépression (bien que non spécifique), et les troubles anxieux évoluent souvent vers des dépressions (l'inverse est très rare).

On peut cependant avoir une **comorbidité entre les deux**; les tableaux cliniques sont plus sévères, le taux de suicide est plus élevé, la chronicité est plus importante, les autres comorbidités sont plus fréquentes et les réponses thérapeutiques sont plus mauvaises.

Nosologie des troubles anxieux

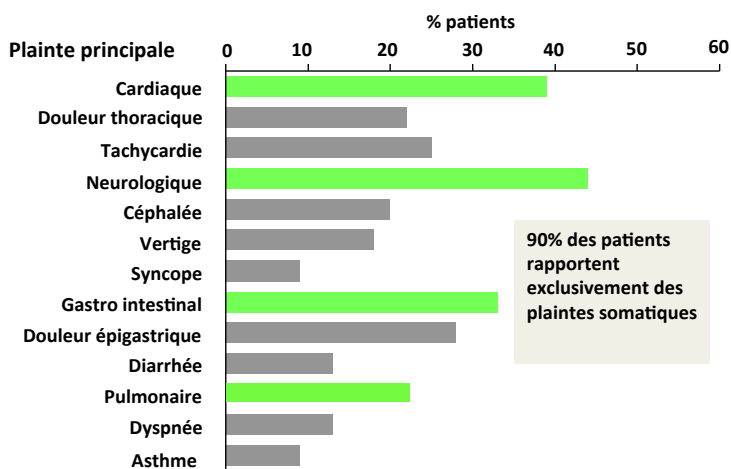
Attaque de panique

L'attaque de panique est la bouffée d'angoisse aiguë, ce que l'épisode thymique est à la dépression. Comme pour la dépression, dans le cas de l'attaque de panique 90% des patients consultent pour des symptômes somatiques.

Il faut donc activement rechercher les symptômes psychiques. On a un **sentiment de malaise paroxystique**, qui peut se présenter sous différentes formes: la peur de s'évanouir, la peur de mourir, la peur de perdre le contrôle, la peur de devenir fou ou de ne pas pouvoir être secouru. On a également une dépersonnalisation et de déréalisation (les patients parlent de diplopie).

Les **symptômes psychomoteurs** sont une activation psychomotrice, qui se traduit par une agitation, une crispation ou une crise clastique. On peut à l'inverse avoir une inhibition, que l'on appelle une sidération stuporeuse, qui immobilise carrément le patient.

Les **symptômes somatiques** sont des palpitations, une tachycardie, un sentiment de gêne ou de douleur thoracique, une dyspnée, un sentiment d'étouffement, d'étranglement et de souffle coupé, une tête vide avec une instabilité et des vertiges, des tremblements et de secousses musculaires, des sudations, des bouffées de chaleur ou des frissons, des nausées ou encore des paresthésies.



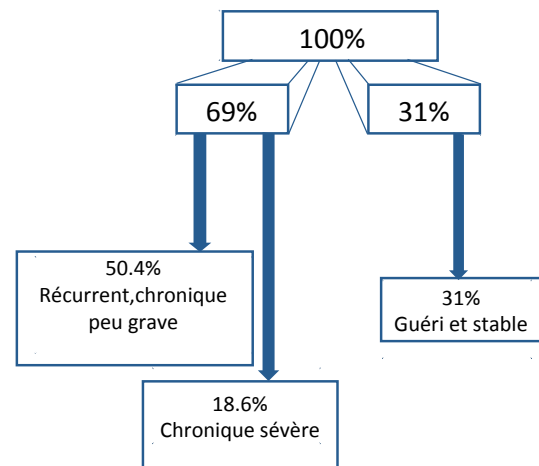
Il y a plusieurs types d'attaques de panique; elles peuvent être inattendues, favorisées par une situation particulière, ou même induite. Plusieurs troubles psychiatriques peuvent en effet induire des troubles de panique, comme la dépression, l'agoraphobie, etc.

Le **trouble de panique** est lorsque l'on a des attaques de paniques récurrentes et inattendues. En général, il débute par une première attaque qui survient sans facteur déclenchant. De plus, on constate la crainte persistante d'avoir d'autres attaques, et/ou une préoccupation des implications possibles de l'attaque (abaisse le seuil de déclenchement de l'attaque suivante). C'est cette **anxiété anticipatoire** qui est la plus handicapante, car le patient commence à développer des conduites d'évitement, et évite de plus en plus de situations car les attaques continuent à survenir.

Phase 1	Attaques spontanées
Phase 2	Sensibilisation
Phase 3	Trouble de panique
Phase 4	Evitement menant à l'agoraphobie
Phase 5	Démoralisation menant à la dépression
Phase 6	Développement de dépendances

Un tiers des troubles de paniques conduisent à l'agoraphobie, via ces processus d'évitement. 50-70% de ces patients sont en dépression, 17% abusent des tranquillisants, 27% abusent d'alcool et 20% se suicident.

Le rétablissement à 7-9 ans est de 12 à 25%. On a des problèmes dans le fonctionnement social, dans le fonctionnement conjugal, et 27% sont dépendants financièrement. Finalement, 12-7 consultations en urgence sont en moyenne nécessaire pour qu'un diagnostic soit posé.



Il y a une susceptibilité génétique. De plus, le trouble de panique touche 2 femmes pour un homme.

En général, on débute la prise en charge avec des benzodiazépines de manière régulière, et **non en réserve** (sinon, risque d'abus puis de dépendance). Puis on donne un inhibiteur de recapture de la sérotonine. Il faut être clair avec le patient sur son trouble, et lui proposer une psychothérapie.

Agoraphobie

L'agoraphobie peut également survenir **sans attaque de panique**. Elle est définie comme une anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile (ou gênant) de s'échapper, ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours en cas de symptômes de type attaque de panique.

Les peurs agoraphobies sont le fait de se retrouver seul en dehors de son domicile, d'être dans une foule ou dans une file d'attente, d'être sur un pont ou dans un autobus, un train ou une voiture.

Les **phobies spécifiques** sont des peurs persistantes et intenses à caractère irraisonné ou bien excessive, déclenchée par la présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique. L'exposition au stimulus phobogène provoque de façon quasi systématique une réaction anxieuse immédiate qui peut prendre la forme d'une attaque de panique liée à la situation ou facilitée par la situation. Le sujet **reconnait le caractère excessif ou irrationnel** de la peur; c'est la caractéristique de l'attaque de panique (bonne compliance)!

Les **phobies sociales** consistent en une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou bien de situations de performance, durant lesquelles le sujet est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attention d'autrui. Le sujet craint d'agir de façon embarrassante ou humiliante, et l'exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi-systématique une anxiété.

	Phobie sociale	Agoraphobie
Sorties	Seul	Accompagné
Achats	Supermarchés	Petits commerces
Restaurant	Coins reculés	Proche de la sortie
Eythrophobie	Fréquente	Aucune

Trouble obsessionnel-compulsif TOC

Les **obsessions** sont la composantes psychiques du TOC, avec des pensées ou des impulsions récurrentes et persistantes, qui sont ressenties comme intrusives et inappropriées. On en a plusieurs types: idéative (doutes), impulsive (acte ou parole transgressifs) et phobique.

Elles entraînent une anxiété ou une détresse importante. Le sujet fait des efforts pour les ignorer ou les réprimer ou pour les neutraliser par d'autres pensées ou actions. Le sujet reconnaît qu'elle proviennent de sa propre activité mentale. Comme pour tous les autres troubles anxieux, il y a une **conscience** que ces peurs sont irrationnelles.

A ces obsessions sont ajoutées des **compulsions**, qui sont des **comportements répétitifs** (lavages, vérifications), ou des actes mentaux, que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible.

Les comportements ou les actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher un événement ou une situation redoutés. Ces TOC sont très envahissants dans la vie du patient, car très ritualisés.

Il y a différentes typologies cliniques de TOC. On peut tout d'abord citer les **laveurs**, qui ont des obsessions phobiques des saletés et des contaminations, qui décroissent avec les rituels, ainsi que les **vérificateurs**, qui ont des obsessions idéatives et qui cherchent à prévenir des catastrophes; dans ce cas, on a peu de décroissance. Puis, on a les **ruminateurs**, qui ont des phobies d'impulsion avec des thèmes transgressifs, ainsi que le **syndrome de lenteur primaire**, dans lequel les actes courants doivent être accomplis dans un ordre précis, ce qui est très chronophage.

Le diagnostic différentiel classique est avec la schizophrénie.

Anxiété généralisée

L'anxiété généralisée est définie par des préoccupations relatives à des événements négatifs mais réalistes de la vie quotidienne dont le sujet **surestime le risque de survenue**. Cela provoque un état d'**hypervigilance**, avec de la tension, de l'irritabilité, de la fatigabilité, des troubles de concentration et de la mémoire, ce qui est très handicapant.

Elle est également caractérisée par la présence de **symptômes fonctionnels chroniques**: céphalées, troubles digestifs, troubles du sommeil, douleurs musculaires.

La prévalence de l'anxiété généralisée est sur-représentée chez le médecins de premier recours, de 3-7% à 8.5% des consultations. L'anxiété généralisée n'est pas toujours correctement diagnostiquée: 28% ne reçoivent aucun diagnostic, 38% sont diagnostiqués avec un problème médical, et 34% avec un diagnostic correct.

Les spécialistes les plus consultés sont des gastro-entérologues (côlon irritable); les plaintes cardio-vasculaires sont également très fréquentes. La majorité des patients se plaignent de symptômes somatiques.

Trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse

C'est le pendant de celui de la dépression; ce n'est pas une bonne manière de déstigmatiser les troubles psychiatriques, et les réserves à poser le diagnostic sont les mêmes que celles pour le pendant dépressif.

Etat de stress post-traumatique ESPT

C'est un trouble fréquent, donc il faut essayer d'assurer le dépistage précoce pour éviter qu'il ne se chronique et devienne très handicapant.

Un facteur déclenchant est nécessaire, qui est une **confrontation directe avec la mort, ou un risque de mort**. Ils se définissent par leur soudaineté, leur intensité et un vécu d'impuissance et de contraire.

On a une réaction de protection immédiate. On a un stress, qui est dû à l'éveil physique et psychologique face à une menace ou un changement dans l'environnement. Cela est suivi par la **dissociation**, qui est la capacité à se déconnecter d'une partie de soi-même lorsque la situation est trop intense; les symptômes dissociatifs sont la torpeur, le détachement, l'absence de réactivité émotionnelle, la réduction de la conscience de son environnement, la déréalisation, la dépersonnalisation et l'amnésie dissociative. On parle d'**état de stress aigu** pour caractériser cette première réaction.

11% des patients évoluent de l'état de stress aigu jusqu'à l'état de stress post-traumatique (surreprésentation chez les femmes), qui est caractérisé par une triade:

Syndrome de remémoration: ce sont des souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement, avec des rêves répétitifs, des impressions soudaines que l'événement va se reproduire, et une détresse psychique lors de l'exposition à des indices évoquant l'événement traumatique.

Syndrome d'évitement: le patient fait un effort pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associées au traumatisme, ainsi que pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent le souvenir du traumatisme. On constate également une incapacité de se souvenir d'un aspect important du traumatisme.

Ensuite, on remarque une réduction nette de l'intérêt pour les activités importantes, avec un sentiment de détachement d'autrui, ou de devenir étranger aux autres. Avec en plus une restriction des affects et un sentiment d'avenir bouché, le retrait de la vie sociale peut être important!!

Activation neurovégétative: on constate des troubles du sommeil, une irritabilité, une difficulté de concentration, une hypervigilance et une réaction de sursaut exagérée.

Immédiatement, on fait un **defusing**, puis le debriefing intervient dans les jours qui suivent. Le defusing consiste à exprimer le vécu immédiat et informer sur les réactions possibles, ainsi

qu'évaluer la nécessité d'un soutien, tandis que le débriefing est plus dangereux dans l'immédiat car peut faire ressurgir des choses.

Ensuite, on peut donner un traitement médicamenteux de suivi, notamment des SSRI. On évite les benzodiazépines, car ils induisent des réactions de stress paradoxal.

Epidémiologie

La mise en évidence n'est pas simple, donc les fourchettes sont larges; on peut dire qu'il y a 3% troubles de paniques, 5% d'agoraphobie, 10% de phobies sociales, et 5% anxiété généralisée.

Traitement des troubles anxieux

Dans l'idéal, on ne prescrit pas de benzodiazépines au long cours, du moins pas plus de 6 semaines; cependant, ce traitement est très efficace en traitement d'attaque. Il ne faut pas le mettre en réserve, de peur de développer des addictions.

Les **thérapies cognitives et comportementales** sont le traitement de choix de ces troubles anxieux. Elle se base sur l'analyse fine du comportement pathologique, afin de monter à la racine du comportement irrationnel. Une fois que les mécanismes sont décortiqués, le thérapeute propose des exercices d'exposition progressive, avec des techniques pour couper court au développement de l'angoisse, notamment avec des exercices de relaxation.

On peut également proposer des psychothérapies psychanalytiques, afin de traiter le trouble de panique, les phobies spécifiques et l'anxiété généralisée. Ce n'est pas un traitement en première intention des TOC et de l'ESPT. On distingue névrose de transfert et névrose actuelle. L'indication est moins liée aux symptômes qu'aux caractéristiques du fonctionnement du patient.

Diagnostic	Traitement
Trouble panique	Alprazolam, SSRI Psychothérapie spécifique
Agoraphobie	Psychothérapie spécifique
Anxiété généralisée	Psychothérapie spécifique SSRI
Phobie sociale	Psychothérapie spécifique Benzodiazépines, SSRI
Phobie spécifique	Psychothérapie spécifique
TOC	Psychothérapie spécifique SSRI
ESPT	Defusing SSRI

Troubles psychotiques

Introduction

Les troubles psychotiques entraînent des symptômes de **pertes de contact avec la réalité**; cela concerne des délires ou idées délirantes, des troubles de perceptions, des troubles du moi ou des troubles formels de la pensée.

Dans le **CIM 10**, on définit la psychose en **termes descriptifs** sans référence théorique à des mécanismes psychopathologiques, utilisé simplement pour indiquer la présence d'hallucinations, d'idées délirantes, de désorganisation de la pensée ou de comportements manifestement anormaux. Les symptômes psychotiques peuvent s'observer dans le contexte de **diverses catégories diagnostiques**; leur seule présence ne permet pas de poser un diagnostic précis.

Le **délire** est une conviction absolue mais erronée, qui est **irréductible** par la logique et l'évidence des faits. Il n'est pas expliqué par l'appartenance à un groupe culturel et par le partage de croyances propres à ce groupe.

On peut classer le délire par rapport au contenu (de persécution, mystique, de grandeur, de référence) ou par rapport à la cohérence (bizarre ou systématisé). Il peut se concevoir comme une **erreur d'interprétation de la réalité**.

Dans les **troubles des perceptions**, on peut dans un premier stade avoir des illusions, qui sont des perceptions faussées du réel, avec un objet qui est mal identifié.

Ensuite, on peut avoir des hallucinations, qui sont des perceptions par une voie sensorielle alors qu'il n'y a pas de stimulus. L'**hallucination** est donc une **perception sans objet**, qui peut toucher toutes les modalités sensorielles. Les hallucinations auditives sont les plus fréquentes (60-70% des patients schizophrènes). Les plus caractéristiques dans la schizophrénie sont des **voix à la 3^e personne**, formulant des commentaires sur le comportement du patient, proférant des insultes, ou plusieurs voix conversant entre elles.

Les hallucinations visuelles concernent 10% des patients, et les olfactives sont fréquentes dans l'épilepsie temporale. Finalement, on peut avoir des hallucinations cénesthésiques (perception de mouvement à l'intérieur du corps) et gustatives.

Les **troubles du moi** sont des troubles de l'éprouvé de l'autre ou de l'environnement, du vécu d'unité du moi ou de l'apparence du moi; on a le sentiment que l'on n'est **plus aux commandes de soi**, de ses mouvements, de ses paroles, de ses pensées.

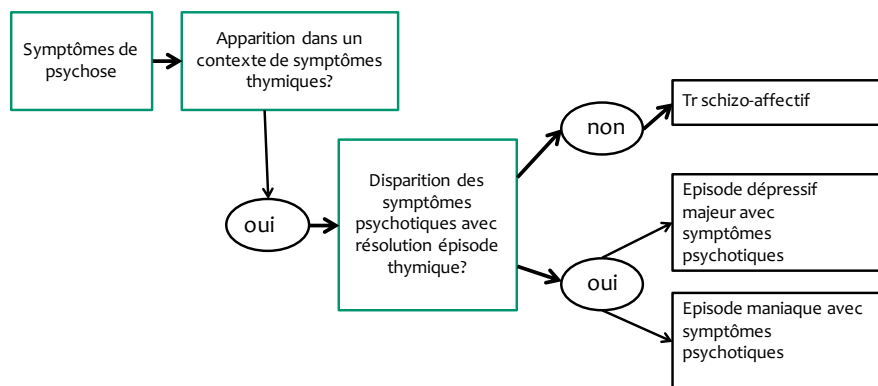
On peut citer la dépersonnalisation (sentiment d'être irréel, transformé), la déréalisation (personnes et objets semblent irréels), le devinement de la pensée (les pensées n'appartiennent plus au patient lui-

même, d'autres y participent et savent ce qu'il pense), le vol de la pensée et les pensées imposées (pensées vécues comme influencées, fabriquées, dirigées ou gouvernées).

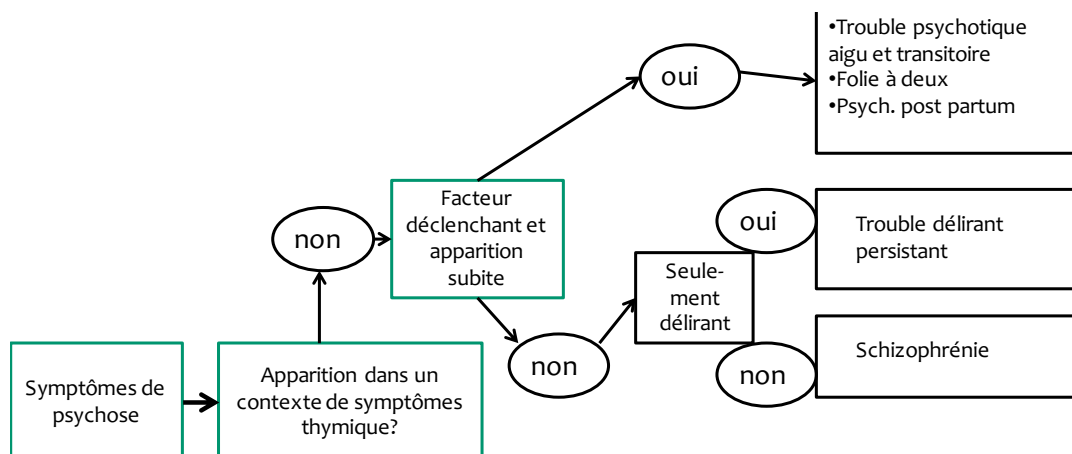
La 4^e dimension possible est le **trouble formel de la pensée**, qui se manifeste dans le langage et traduisent un flux ou une organisation déficiente de la pensée. La pensée peut être ralentie ou circonscrite (ne distingue pas l'essentiel de l'accessoire); on peut avoir des fuites d'idées (afflux d'idées qui ne sont pas dirigées par un projet; le but de la pensée est en changement permanent), des réponses à côté (même à des questions simples), des néologismes et une pensée incohérente.

Classification

Lorsque l'on a des symptômes de psychose, on commence par exclure les éventuelles causes somatiques (toxiques, infectieuses, encéphalite, métastases,...). Ensuite, on se demande s'ils sont apparus dans un contexte de symptômes thymiques (dépression, manie). Si c'est le cas, on parle de **psychoses affectives**, et on se demande si les symptômes disparaissent avec la résolution de l'épisode.



Dans les **psychoses non-affectives**, donc qui sont présents indépendamment des variations de l'humeur, on se pose la question de l'existence d'un **facteur déclenchant récent**.



S'il y a un facteur déclenchant, on distingue 3 sortes de troubles:

Trouble psychotique aigu transitoire: ils sont d'apparition aiguë, en deux semaines ou moins. Ce sont des troubles qui apparaissent en présence d'un facteur de stress aigu (deuil, traumatisme, perte inattendue d'une relation affective ou d'un emploi, etc.); plus il apparaît rapidement, meilleur est le pronostic. Il y en a deux formes, selon le type de symptômes psychotiques présents.

Dans le polymorphe, la symptomatologie change rapidement au cours de la journée; on a la présence fréquente d'un bouleversement émotionnel, des passages d'extase à irritabilité et anxiété. Dans ce cas, l'apparition est brutale, et la disparition rapide; s'il persiste plus de 3 mois, il faut revoir le diagnostic pour un trouble délirant persistant.

Si le trouble psychotique aigu transitoire est d'allure schizophrénique, on a moins de variation au cours de la journée, avec des symptômes schizophréniques importants, comme les troubles du moi et des bizarreries, qui sont relativement stable. S'il persiste au-delà d'un mois, il faut modifier le diagnostic pour une schizophrénie.

Folie à deux: C'est un trouble délirant rare, qui est partagé par deux ou un groupe de personnes. Une seule des personnes présente un trouble psychotique authentique (arguments chronologiques), et les idées délirantes induites chez les autres personnes disparaissent en cas de séparation. Les thèmes habituels sont la persécution et la grandeur; les hallucinations sont extrêmement rares. Dans la plupart des cas, il est lié à l'établissement d'une **relation d'une intensité inhabituelle** (raisons culturelles, linguistiques, sociales, ...).

Psychose post-partum: Elle est d'apparition rapide, chez des femmes habituellement sans antécédent psychiatrique, dans les 6 à 48 heures après l'accouchement. Elle est caractérisée par de l'euphorie, une hyperactivité, une fuite des idées, une hyper-sociabilité et des troubles du sommeil, ainsi qu'un délire à son propre sujet ou à celui de l'enfant. On a des possibilité d'éléments dépressifs également.

L'évolution sans traitement est incertaine, et peut durer plusieurs mois; de plus, on a un risque majeur pour l'enfant, donc cela demande un encadrement important. Le traitement commence avec des anxiolytiques, et on peut devoir recourir à des neuroleptiques; on fait bien entendu des hospitalisations mère-bébé.

S'il n'y a pas de facteur déclenchant, on a d'un côté le trouble délirant persistant, qui est seulement délirant, et la schizophrénie, qui a d'autres symptômes additionnels.

Le **trouble délirant persistant**, ou délire paranoïaque chronique dans la terminologie française, est un trouble marqué par la présence isolée d'une symptomatologie délirante, sans autres symptômes psychotiques. Le délire est systématisé, habituellement paranoïaque ou de grandeur. Cette pathologie répond assez mal au traitement neuroleptique, donc l'évolution est souvent défavorable.

Le **trouble schizo-affectif** se trouve à la frontière des deux, mais on a plutôt tendance à le classer dans les psychoses affectives. C'est un trouble épisodique marqué par la présence conjointe de symptômes affectifs, comme la manie ou la dépression, et de symptômes psychotiques, ainsi que par la présence des symptômes psychotiques au-delà de 2 semaines après la résolution de l'épisode affectif.

Schizophrénie

Généralités

Comme pour la plupart des diagnostics psychiatriques, le terme schizophrénie s'applique à un **groupe hétérogène de troubles**. Ces troubles ont en commun un certain nombre de symptômes (négatifs, troubles cognitifs, symptômes psychotiques dans les phases aiguës), ainsi qu'une présence pendant plus d'un mois.

On avait une classification, en schizophrénies paranoïde, hétéroforme (prédominance de désorganisation de la pensée), catatonique (stupeur ou excitation), indifférenciée et résiduelle (symptômes positifs atténués), qui a été abandonnée aujourd'hui.

C'est une maladie qui n'est pas si rare que ça, et qui touche **1% de la population**; il y en a plus dans les milieux urbains. L'incidence est de 2 nouveaux cas sur 10'000 habitants par année. Le début est entre 18 et 25 ans chez les hommes, et 24 et 35 ans chez les femmes (avec un second pic à la ménopause). L'espérance de vie est 20% inférieure à celle de la population générale, et les causes principales sont le suicide, les maladies respiratoires et infectieuses, l'abus de substances et les maladies cardiovasculaires.

A long terme, on constate 25% de guérison, 25% de formes avec récurrences, et 50% de formes à évolution plus chronique et défavorable.

Le concept de schizophrénie a 100 ans; avant, on parlait de démence précoce. Pour Bleuler, on avait un phénomène primaire, de base organique. Ces **symptômes fondamentaux** sont des

associations relâchées, des troubles des affects, une ambivalence, un autisme (intérêt pour son monde intérieur), ainsi qu'une abolition et des troubles de l'attention.

A cela s'ajoute des **symptômes secondaires**, issus de la réaction du psychisme du malade, qui apparaissent pendant les phases aiguës. On peut citer les hallucinations, les idées délirantes, les troubles cognitifs et les symptômes catatoniques.

Plus tard, le concept a évolué, et on parle de symptômes positifs et de symptômes négatifs.

Symptômes positifs: On peut citer les hallucinations, le délire, les troubles de la pensée formelle et le comportement désorganisé.

Les symptômes positifs ne sont pas pathognomoniques de la schizophrénie, et plus typiques de la phase aiguë de la maladie. Ces symptômes répondent mieux aux anti-psychotiques, et sont liés à une hyperactivité dopaminergique de la voie méso-limbique.

Symptômes négatifs: On cite l'affect aplati, l'algie, l'anhédonie et le retrait social, ainsi que l'apathie.

Les symptômes négatifs sont plutôt présents entre les épisodes. Ils sont associés à un état déficitaire, à un mauvais fonctionnement pré-morbide et à un mauvais pronostic. Ils sont relativement stables et peu ou pas réversibles, ainsi que difficiles à différencier des symptômes dépressifs. On a une résistance aux antipsychotiques, et ils sont liés à une hypoactivité dopaminergique de la voie méso-corticale.

Les **troubles cognitifs** sont présents chez 60-80% des patients, et sont aussi présents chez les proches de premier degré (composante génétique de l'organisation du cerveau?), et sont déjà présents dans la phase prodromique. Les compétences cognitives sont importantes pour la réhabilitation et déterminent le pronostic. Les domaines de déficit les plus fréquents sont l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives et la cognition sociale.

Etiologie

La schizophrénie n'est **pas liée à un seul facteur**, mais à l'interaction de divers facteurs intrinsèques et extrinsèques. Les facteurs de risque prémorbides confèrent une vulnérabilité.

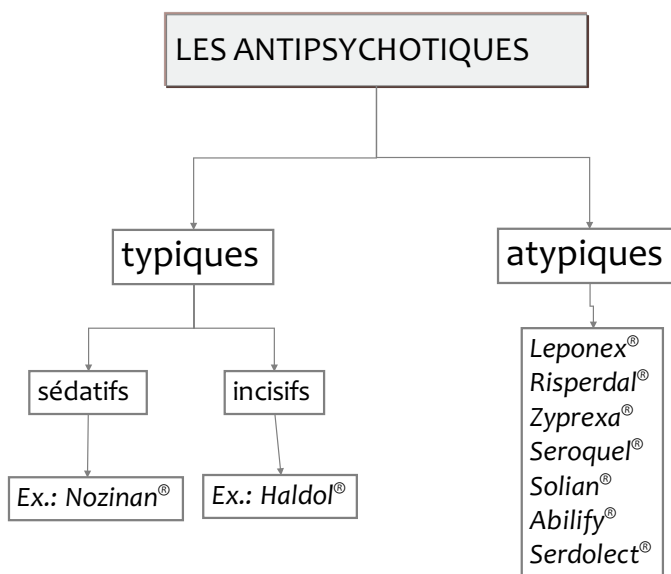
Il y a plusieurs **facteurs qui influencent la vulnérabilité**, à savoir biologiques (génétique, lésions cérébrales, complications obstétricales, déficit en glutathion), ainsi que psychologiques et environnementaux (trauma psychologique/sexuel, migration, THC ou autres substances, urbanité).

On n'a que des **hypothèses** (neuro-développemental, neurotransmetteurs), mais pas de mécanismes extrêmement claires de développement de la schizophrénie. Les patients atteints de schizophrénie

présentent fréquemment des pathologies associées, comme la dépression, l'abus de substances, les TOC et l'anxiété.

Traitement

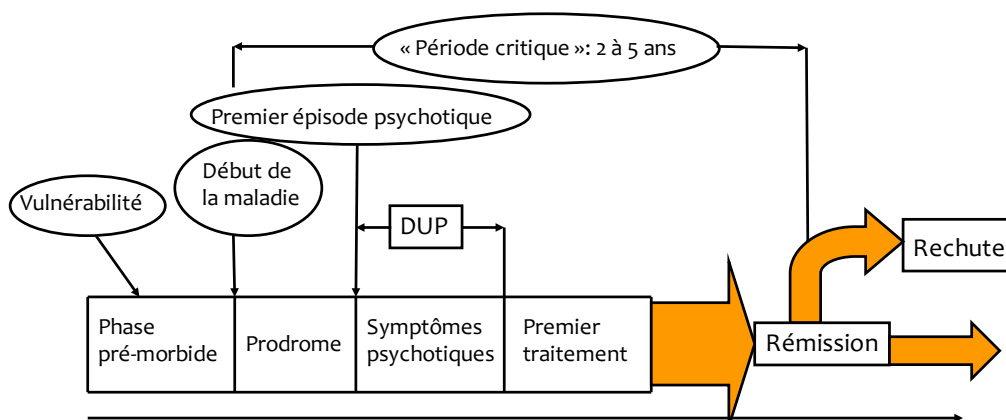
La prise en charge est **pluridisciplinaire**. On combine des traitements biologiques, les neuroleptiques, avec de la psychothérapie, des traitements psychologiques, des traitements psycho-sociaux, ainsi qu'une réhabilitation et un soutien à l'emploi. La majorité des prises en charge se fait en **milieu ambulatoire**.



Intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques

La grande majorité des patients schizophrènes qui sont soignés n'accèdent aux soins que beaucoup trop tardivement.

Plusieurs études démontrent en effet qu'il y a un long délai entre l'apparition des symptômes et le début du traitement (***durée de psychose non-traitée DUP***), en moyenne de 2 ans pour la schizophrénie. De plus, il existe une « **période critique** » durant les deux à trois premières années de la maladie pendant laquelle s'installent plusieurs déficits qui tendent ensuite à se stabiliser. Finalement, au début des psychoses on a beaucoup de peine à poser un diagnostic.



Un premier **objectif** des programmes spécialisés que l'on a mis en place dans le traitement est de **diminuer le délai** entre l'apparition des symptômes de la maladie et le début du traitement,

notamment en identifiant les sujets à risque pour intervenir dans la phase des prodromes (que l'on sait mieux identifier aujourd'hui) ainsi que lors du premier épisode psychotique. Le second objectif est une ***adaptation du traitement*** à ce stade particulier de la maladie.

Il y a beaucoup de recherche au niveau de l'***intervention dans la phase des prodromes***, mais ces interventions ne sont pas encore dans la routine, et on a encore beaucoup de problèmes à régler. Certains critères cliniques permettent d'identifier des patients avant qu'ils n'atteignent le seuil de psychose floride (70% de faux-positifs! échelles très peu spécifiques); cette identification nécessite une connaissance des mécanismes qui sous-tendent l'émergence d'une psychose.

Quelques groupes ont démontré une diminution du taux de transition du prodrome vers la psychose par diverses formes d'intervention. Evidemment, intervenir chez ces patients qui ne développeront peut-être pas de psychose est éthiquement discutable, et ces approches sont limitées dans le cadre de la recherche.

Ensuite, il est important d'intervenir ***après le premier épisode psychotique***. On constate en effet que 13% des patients ont tenté de se **suicider** avant leur admission. De plus, l'**abus de substance** (50-70%) est très présents chez ces patients psychiatriques, la plupart du temps pour se sentir moins mal avec leur symptômes; cette consommation commence pour la moitié durant la DUP.

40% de ces patients sont déjà **sans emploi** ou sans activité à l'entrée dans le programme, ce qui perturbe le processus de développement. On constate une **détresse** importante, ainsi qu'ensuite une **péjoration de la réponse au traitement** (récupération lente, moins bonne qualité de vie après rémission). L'enjeu du traitement précoce est donc très clair!

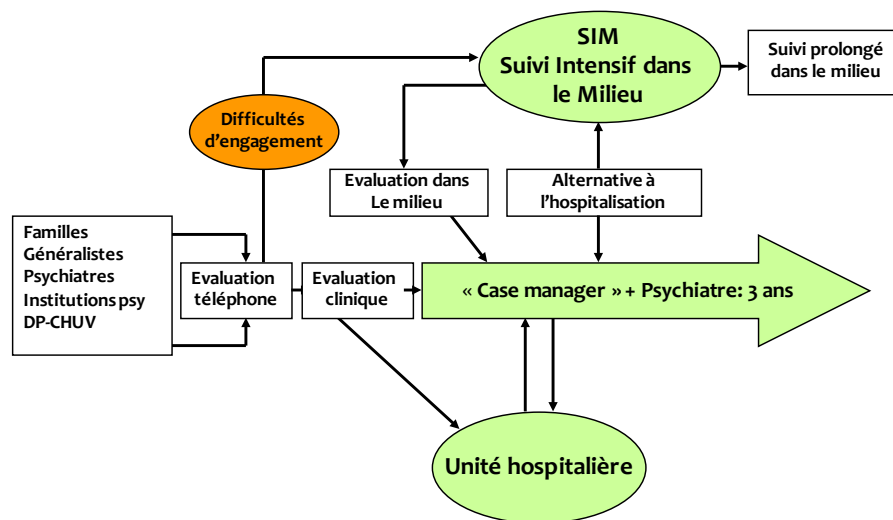
Pour agir sur le ***DUP pré-diagnostique***, on informe le public (maladie sérieuse, qui nécessite une prise en charge précoce pour bien évoluer), ainsi que les médecins de premier recours. Il faut améliorer l'identification des patients, car la ***présentation est souvent peu typique*** au début de la maladie (perte de contact social, repli sur soi). L'observation des proches est pour cela très importante.

Le vécu du patient est également peu spécifique, et plus les symptômes sont marqués, plus les jeunes ont tendance à les cacher. Il faut penser à la psychose en présence de certains **facteurs de risque**, comme l'âge (adolescence ou jeune adulte), un risque constitutionnel (anamnèse familiale, complications obstétricales, retard de développement, trouble schizotypique) et un risque acquis (événement stressant ou trauma récent, abus de substance).

Pour agir sur le DUP ***post-diagnostique***, il faut **renforcer l'accessibilité aux soins**, adapter le traitement, améliorer l'adhérence au traitement et faire un travail spécifique d'engagement du

patient dans les soins (optimisme, soins orientés vers le rétablissement, partenariat, information, flexibilité).

On propose un **programme TIPP pour 3 ans**, avec des médecins mais également des « **case manager** » (très supervisés pour être à jour), des infirmiers qui sont présents tout au long du suivi, et qui travaillent en partenariat étroit avec les psychiatres. Il peut y avoir des difficultés d'engagement après le diagnostic, et il existe pour cela des personnes qui vont à domicile à la rencontre des patients (ne viennent pas aux consultations psy, trop stigmatisants). Pour éviter l'hospitalisation (faible hospitalisation; en moyenne, 1.2 séjours) pour les patients qui vont moins bien, on peut intensifier le suivi jusqu'à 2 fois par jour, pour éviter de les couper de leur monde.



On essaie d'abord de **traiter par des benzodiazépines**, pour enlever l'anxiété et voir si les symptômes disparaissent (observation 24-48h). Si cela ne fonctionne pas, on commence des **neuroleptiques** à très faible dose, en favorisant les atypiques (nouvelle génération, moins d'effet secondaire, mais prise de poids sévère => nécessite un suivi métabolique rapproché), tout cela pour éviter les effets secondaires. Il faut suivre la réponse, et adapter le traitement en cas d'absence de réponse.

Dans ces programmes, on a une certaine stratégie pour renforcer l'engagement, notamment avec ces « case manager » qui les suivent tout au long du traitement. Le but est de parler des problèmes concrets du patient. Il est important de corriger les fausses croyances très pessimistes du patient sur la maladie, et de parler de ses ressources.

Malgré tout cela, il y a à peu près **25% des patients se désengagent des soins**. On a certains facteurs prédictifs, comme des démêlés avec la justice (expérience négative de l'institution), des patients qui n'avaient pas des symptômes très marqués, une absence de liens avec la famille, ainsi qu'une persistance d'abus de substance.

Finalement, ce genre de programme est plus efficace, et de plus moins coûteux. Malheureusement, tous les cantons n'ont pas encore mis cela en place.

Troubles de la personnalité

Tempérament, caractère et personnalité

La théorie des tempéraments de l'antiquité grecque est en rapport avec celle des humeurs, et nous illustre que l'on tente de définir la personnalité depuis très longtemps.

On emploie couramment 3 termes pour définir cette entité qui nous caractérise. Premièrement, le **tempérament** est l'aspect biologique de notre fonctionnement, ce qui nous a été donné à la naissance. Ensuite, le **caractère** est forgé par notre environnement (notamment familial), par ce que l'on a vécu. La **personnalité**, finalement, c'est ce que chacun fait de son tempérament et de son caractère.

Nosologie et diagnostic

Le trouble de la personnalité peut être défini comme étant une modalité de l'expérience vécue et des conduites qui dévient notamment de ce qui est attendu dans la culture de l'individu. Il touche l'**ensemble du fonctionnement** du sujet, soit cognitif, affectif, comportemental et relationnel. Les traits de caractère qui deviennent pathologiques se rigidifient, et sont durables et envahissants. Ce trouble doit être décelable au plus tard à l'adolescence ou au début de l'âge adulte.

Le diagnostic de trouble de la personnalité est très important, car ce trouble **altère globalement la vie du patient**; c'est une souffrance diffuse, qui est difficile à mettre en mot. Ce sont de plus des facteurs de risque pour les troubles de l'axe I (troubles majeurs cliniques), avec des répercussions marquées sur l'entourage, qui complique donc la relation médecin-malade. Le traitement est long et souvent difficile; la psychothérapie au long cours est le seul traitement curatif.

La démarche diagnostic est donc complexe; l'~~entretien clinique usuel~~ n'est pas très bon pour diagnostiquer un trouble de la personnalité. Il existe des instruments standardisés en psychiatrie, qui donnent des bons résultats, mais le problème est que pour faire ces entretiens semi-structurés, on a besoin de beaucoup de temps et ces entretiens sont très ennuyeux, avec des questions plutôt fermées. Finalement, on a des formes d'entretien plutôt de type **psychodynamique**, plus sensible, permet de mettre en évidence les difficultés fonctionnelles du patient.

Problèmes

Il existe différentes manières de circonscrire le caractère, mais qui ne sont jamais suffisantes prises individuellement.

1. **Critères statistiques**: est pathologique ce qui dévie de la norme (qu'il est problématique de définir)

2. **Critères dimensionnels**: est pathologique ce qui est à une valeur extrême de la dimension définie. Par exemple, sur la base d'analyses statistiques de questionnaires remplis par les sujets, on pourrait mettre en évidence 5 facteurs: extraverti, agréable, consciencieux, névrosé, ouvert.
3. **Critères catégoriels**: est pathologique ce qui correspond aux critères du pathologique définis a priori
4. **Critères adaptatifs**: est pathologique ce qui entrave l'adaptabilité sociale
5. **Critères subjectifs**: est pathologique ce qui cause une souffrance ou un conflit intra-psychique

On n'a pas la même classification dans le DSM-V que dans la CIM-10, ce qui reflète la difficulté diagnostic et de définition de ce genre de troubles. La fourchette de fréquence pour les troubles de la personnalité varie entre 0 et 5% en général; c'est une entité qui est relativement difficile à circonscrire, car certaines études ont eu plus de peine à les mettre en évidence.

Alors même que les troubles de la personnalité devrait être stables par définition, il y a des patients sur une année qui correspondent aux critères à certains moments, puis à d'autre non. Certaines personnes ne correspondent en effet aux critères qu'en situation de crise; si le diagnostic est posé, c'est parce que l'état des personnes durant cette période colore leur biographie. Donc, pour éviter cela, il faut **éviter de poser le diagnostic de trouble de la personnalité après un seul épisode de soin!**

Catégories

On a plusieurs catégories, qui peuvent être utilisés comme des prototypes, comme un système de repère. Une seule catégorie peine à définir la richesse de la personnalité de quelqu'un.

Groupe A: bizarres et excentriques

Ce groupe s'inscrit dans le groupe des psychoses.

Personnalité paranoïaque

Ces patients consultent plutôt pour des **troubles dépressifs** consécutifs à leurs difficultés à s'adapter à un environnement.

On constate donc une **hypertrophie du moi**, avec un égocentrisme et une surestimation de soi; il y a une sorte d'assurance implicite dans tous ce qu'ils affirment et font, et ils ne se remettent jamais en question. Ce sont des gens psychorigides, avec un **autoritarisme** et une absence de doute. Ce sont des gens **méfiant**s, qui s'attendent à ce qu'on les exploite et les trompe, qui

doutent de la fidélité de leurs amis, de leur conjoint, et ne se confient pas. Ils sont très susceptibles, interprétatifs, suspicieux et rancunier.

Elle fait partie des **troubles du spectre de la schizophrénie**; en effet, des patients porteurs du gènes de vulnérabilité pour la schizophrénie peuvent ne pas développer cette maladie, mais en revanche certains de ces troubles de la personnalité du groupe A.

Sa prévalence est comprise entre 0 et 4.5%. C'est une des formes de TP qui est difficile à traiter, en raison des traits de caractère. Ce sont des patients avec qui ont peut faire alliance un certain temps, mais ils ne supportent pas la moindre déception (mesures procédurières; colérique => faire attention).

Personnalité schizoïde

Ces personnes sont **en retrait par rapport aux relations sociales**; ils sont solitaires et ne cherchent ni n'apprécient les relations proches, et qui n'ont que peu d'intérêt pour les relations sexuelles.

On constate une ***pauvreté de leur registre émotionnel***, avec une indifférence aux critiques et aux éloges, peu d'activités qui procurent du plaisir, ainsi qu'une froideur affective. Elle ne fait probablement pas partie des troubles du spectre de la schizophrénie, avec une prévalence de 0 à 4.1%, plus importante chez les hommes.

Personnalité schizotypique

On peut voir ces caractéristiques chez un schizophrène en rémission, notamment. Ces patients ont un fonctionnement caractérisé par un certain nombre de ***difficultés cognitives***, qui sont définies par une absence de capacité de se mettre à la place de l'autre, ce qui génère des **maladresses relationnelles desquelles ils sont conscients**.

Ils sont donc toujours inquiets de ces interactions, et se retrouvent dans un isolement social dans lequel ils sont **malheureux**. On constate également une distorsion des perceptions et des cognitions, avec des troubles fins du discours (utilisation bizarre des expressions de la langue courante) et de la pensée, des croyances bizarre et des idées de référence.

On a également une pauvreté ou une inadéquation des affects, ainsi que des conduites excentriques. Ce trouble de la personnalité fait partie des troubles du spectre de la schizophrénie, et sa prévalence est de 0 à 5.6%. La prise en charge est essentiellement psychothérapeutique; on peut utiliser également des neuroleptiques (parfois aussi pour la personnalité paranoïaque), ou encore une remédiation des troubles cognitifs.

Groupe B: dramatiques

Personnalité antisociale

Dans cette personnalité, on a un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, qui se traduit par une incapacité à se conformer aux règles et aux normes (inutilité des règles), une tendance à tromper par profit ou par plaisir, une absence de culpabilité et une absence d'empathie et de remords.

Ces patients sont irritables et agressifs, ils ont une **incapacité à avoir des relations durables**, et cela peut faire suite à un trouble des conduites à l'adolescence.

On a également une longue histoire relative à la « psychopathie »; ce trouble est beaucoup plus fréquent chez les hommes, avec une prévalence générale de 0-2 à 3.3%. L'étiologie est discutée (traumatisme, abandon, génétique, maltraitance), et le traitement est difficile. Cette pathologie est en effet classiquement considérée comme une contre-indication aux psychothérapies standards.

Personnalité borderline

C'est un trouble de la personnalité qui fait partie des plus étudiés, et qui a une prévalence de 0 à 4.6%, et qui est plus **fréquent chez les femmes**. L'incidence est plus élevée dans les familles avec des troubles de l'humeur ou des troubles liés à une substance. On constate également des liens complexes avec les troubles de l'humeur. L'étiologie est discutée (violence dans l'enfance?), et elle peut s'améliorer avec les années.

On constate **4 aspects** de ce trouble de la personnalité:

Perturbation des émotions: on a une réactivité marquée de l'humeur, avec notamment des colères intenses et inappropriées. Comme ces patients ont des représentations conflictuelles de certains aspects, on constate souvent un sentiment de vide, qui est plus facile à supporter intellectuellement.

Impulsivité: on peut remarquer des gestes ou des menaces suicidaires, ou des auto-mutilations, ainsi que des troubles alimentaires et des addictions.

Perturbation de l'identité: on constate une instabilité de l'image de soi et des autres. De plus, on peut observer une idéation persécutoire.

Relations interpersonnelles instables et intenses: ce sont des patients touchant, mais compliqués. Ils ont une crainte d'abandon, qui dramatisent tout.

Ce sont des patients qui ont une identité diffuse. Lors de l'anamnèse, il y a plein de comportements contradictoires, et les états affectifs sont instables ou disproportionnés. De plus, on a des **représentations de soi et des proches imprécises ou contradictoires**. Les relations sont décrites comme intenses alors qu'elles sont superficielles.

Les **mécanismes de défense** portent atteinte à la nature du lien entre la représentation de soi et d'objet. On peut citer le clivage, le déni, l'omnipotence, l'idéalisation primitive et la dévalorisation.

Ces patients sont souvent déprimés, mais c'est plus une **dépressivité caractérielle** (ne se traite pas par des antidépresseurs) plutôt qu'un état dépressif majeur. Mais le patient borderline peut aussi faire des épisodes dépressifs majeurs!

Dépression majeure	Dépressivité caractérielle
Humeur dépression stable	Brusques variations de l'humeur
Perte d'intérêt pour l'environnement habituel	Humeur réactionnelle à des stimuli environnementaux
Sentiment de culpabilité	Critiques adressées à autrui
Idées de mort précède et accompagne les tentatives de suicide	Tentatives de suicide impulsives sans idées de mort
Fonctionnement stable ou légèrement déprimé entre les épisodes	Fonctionnement instable entre les épisodes
Culpabilité, remords, baisse de l'estime de soi	Sentiments de solitude, de vide et d'ennui alternant avec des sentiments de rage et de frustrations

On a également un **diagnostic différentiel compliqué par le trouble bipolaire II**; mais chez le patient borderline, on n'a pas d'épisode psychotique. Le trouble bipolaire est beaucoup plus handicapant sur le plan social et professionnel.

On peut avoir plusieurs étiologies, au niveau biologique comme au niveau relationnel/psychologique (séparation ou perte, troubles psychiatriques familiaux, négligence et contrôle excessif, abus sexuel, attachement angoissé ambivalent).

Il n'y a pas de traitement pharmacologique du trouble de la personnalité. Par contre, on peut utiliser des médicaments en cas de co-morbidité spécifique.

Le trouble est traité en **psychothérapie de longue durée** (5 ans et plus), qui nécessite un contrat thérapeutique et peut impliquer une hospitalisation. Il ne faut pas interpréter les conflits immédiatement, car le patient risque de se mettre en colère. On peut tester l'épreuve de réalité, et relever la confusion.

Personnalité histrionique

Proche de la personnalité borderline, cette personnalité a **tendance à la dramatisation**. Il existe quelques doutes quant au bien fondé diagnostic de cette personnalité. On aurait des réponses émotionnelles excessives, avec une manière de parler subjective et pauvre en détails, ainsi de la considération de ses relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité.

Ensuite, on remarque une **quête d'attention** avec le souhait d'être le centre de l'attention, et une théâtralisation de l'expression émotionnelle. Finalement, ce sont des personnes très suggestibles, donc facilement influencées par autrui ou par les circonstances. Les étiologies et le traitement sont les mêmes que pour la personnalité borderline.

Personnalité narcissique

On a un paradoxe, car d'un côté un sens grandiose de sa propre importance, et de l'autre un besoin excessif d'être admiré. On a des comportements volontiers arrogants et hautains. Ces patients pensent que tout leur est dû, exploite les autres et manquent d'empathie.

Groupe C

A l'inverse des autres, ces patients ont une assez bonne conscience de leur difficulté.

Personnalité évitante

Ce trouble est caractérisé par un **sentiment de ne jamais être à la hauteur**; le patient se perçoit comme socialement incompetent, sans attrait ou inférieur aux autres. On a une hypersensibilité au jugement d'autrui, avec une crainte d'être critiqué ou rejeté.

Ainsi, cette peur entraîne une **inhibition sociale**, caractérisée par une timidité, une personnalité effacée et émotive. Ces patients ont typiquement une réticence à s'impliquer avec autrui à moins d'être certain d'être apprécié.

Les diagnostics différentiels sont la phobie sociale et la personnalité schizoïde. La prévalence de ce trouble est comprise entre 0 et 5.2%, et il apparaît souvent dans l'enfance. Le traitement est la psychothérapie.

Personnalité dépendante

On a le **même noyau de manque de confiance en soi** que dans la personnalité évitante, mais la réaction est opposée; on peut donc observer ces deux types de troubles chez le même patient!

Ces patients ont un **besoin général et excessif d'être pris en charge**; ils ont besoin que d'autres assument les responsabilités, et ont des difficultés à prendre des décisions seuls. Ils adoptent un comportement soumis et passif, caractérisé par un manque d'initiative et un problème à exprimer

un désaccord avec autrui. Finalement, ils sont angoissés de la séparation; lorsqu'une relation proche se termine, ils cherchent de manière urgente une autre relation.

La prévalence est de 0.4 à 10.3%, et ce trouble est plus fréquent chez les femmes. L'état dépressif majeur est une complication, et le traitement est la psychothérapie.

Personnalité obsessionnelle-compulsive

Ces patients ont un **besoin excessif d'ordre matériel et moral**, avec des préoccupations pour les règles et l'organisation au point que le but principal de l'activité est perdue de vue, et évidemment du perfectionnisme. On constate également des soucis d'économie, et une tendance aux doutes et aux scrupules qui se manifeste par de l'indécision.

Finalement, on constate également un ***entêtement*** et une ***rigidité***; ces patients sont trop consciencieux et rigide sur des questions de morale, et réticents à travailler avec autrui à moins que les autres se soumettent exactement à sa manière de faire les choses.

La prévalence est comprise entre 0 et 9.3%, et ce trouble est plus fréquent chez les hommes. Si on a de véritables obsessions et compulsions, on pose le diagnostic de TOC. Les complications sont l'état dépressif majeur, ainsi que la dépendance à l'alcool. Le traitement est psychothérapeutique.

Trouble de la personnalité non-spécifié

C'est une catégorie qui englobe tous les troubles de la personnalité que l'on ne peut pas classer dans les autres catégories.

Addictions

Éléments de contexte

La Suisse a été par le passé complètement débordée par les drogues, ce qui a engendrer un important traumatisme; on a donc mis des choses en place pour éviter que cela ne se reproduise. La politique suisse dans la gestion des drogues consiste donc en **4 piliers**: prévention, répression, thérapie, et aide à la survie (sujets qui font débat, notamment locaux d'injection, prescription médicale d'héroïne, etc.).

On est également passé d'un discours sur les substances à un discours sur les personnes. Aujourd'hui, l'âge des consommateurs a diminué, tandis que l'accessibilité aux substances augmente. Tout cela est bien entendu catastrophique du point de vue de la santé publique, avec ce que l'on appelle une polymorbidité médico-psycho-sociale.

Avant, on avait le dogme du ***jugement moral***. Les addictions étaient perçues comme un vice, une mauvaise volonté ou de la paresse, avec des patients difficiles. Tandis que certaines substances étaient diabolisées, d'autres étaient banalisées. On déléguait cela au monde social, en pensant dédaigneusement que ce n'était pas de la médecine, et on avait donc une discordance entre l'offre et le besoin.

En 20 ans, on est passé au ***jugement clinique***; l'addiction est devenue une maladie complexe, au carrefour du psychosomatique et du psychosocial. Ces patients sont pris en considération du point de vue de leurs vulnérabilités biologiques, psychologiques et sociales. On a un fondement scientifique à cette prise en charge. On fait de la bonne médecine, en synthétisant les connaissances, en s'appuyant sur la clinique et en centrant la pratique sur les besoins des patients.

Substances psycho-actives

Psycholeptiques

C'est le groupe des sédatifs ou des **dépresseurs du SNC**, qui à petite dose provoque une désinhibition et une anxiolyse, qui peut aller jusqu'à une sédation, un coma ou même un arrêt respiratoire à haute dose. On peut citer l'**alcool**, les benzodiazépines, les barbituriques et autres hypnotiques, le GHB ainsi que les opiacés.

Psychoanaleptiques

C'est le groupe des **stimulants du SNC**; les effets recherchés sont euphoriques et entactogène (amplifie la capacité d'empathie, le désir de contact avec autrui), les effets somatiques sont une

excitation, une hypertension voire des convulsions (la cocaïne est une des premières causes de convulsion), et les effets psychiques sont une agitation, une diminution du sommeil, une stimulation de la libido, des compulsions stéréotypées et de la paranoïa.

On peut citer la caféine, la **nicotine**, les amphétamines et leurs dérivés (ecstasy, MDMA, pilules thaïes), ainsi que la cocaïne (3-5% des Suisses!).

Psychodysléptiques

Ce groupe est celui des **perturbateurs du SNC**, comme le **cannabis**, les solvants, la mescaline, le LSD et la phencyclidine. L'effet recherché est la déconnexion, et les effets psychiques sont une dissociation, la panique, la paranoïa et les hallucinations (ne pas oublier).

Éléments de classification et de diagnostic

L'**addiction** est définie par un ensemble de troubles dans lesquels on constate un asservissement de la personne par le corps, avec ou sans substances psycho-actives. On a un comportement de recherche active, ainsi qu'une automatisation expliquée par la plasticité neuronale.

La **dépendance** est son degré le plus sévère, et est définie par un syndrome avec des symptômes psychobiologiques, comme le sevrage ou la tolérance. Dans le DSM IV, la dépendance est définie comme la présence d'au moins trois des manifestations suivantes dans les 12 mois:

1. Tolérance
2. Sevrage
3. Substance souvent prise en quantité plus importante ou prolongée
4. Désir persistant
5. Temps passé en activités nécessaires
6. Utilisation poursuivie malgré la connaissance d'un problème psychique ou physique persistant.

Pour toutes les substances, on a une consommation récréative, une consommation à risque qui peut engendrer potentiellement des problèmes, ainsi qu'un abus, qui intervient à partir du moment où ces problèmes sont avérés.

L'**abus**, dans le DSM IV, est donc un **mode d'utilisation inadéquat d'une substance**, avec au moins une des manifestations suivantes, dans les douze mois:

1. Incapacité de remplir des obligations majeures
2. Utilisation répétée dans des situations dangereuses
3. Problèmes judiciaires répétés et en lien avec cette substance
4. Utilisation malgré les problèmes

Cependant, avec le DSM V, on a **supprimé la distinction entre abus et dépendance**; on n'a plus qu'un trouble qui combine les deux, « substance use disorder », qui est gradé de léger à sévère. Pour poser un diagnostic, il faut observer 2-3 symptômes parmi 11. On a retiré les problèmes avec la loi de la définition, et ajouté le « craving » à la liste. Ensuite on a également un autre concept, « addictive disorder », qui inclut notamment les problèmes de jeu.

Dans le CIM-10, on a une classification des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de diverses substances psycho-actives:

- F10. : Alcool
- F11. : Opiacés
- F12. : Dérivés du cannabis
- F13. : Sédatifs ou hypnotiques
- F14. : Cocaïne
- F15. : Autres stimulants, y compris la caféine
- F16. : Hallucinogènes
- F17. : Tabac
- F18. : Solvants volatils
- F19. : Drogues multiples et autres substances.

Après le point, on met un chiffre de 0 à 9 pour qualifier les manifestations associées à la consommation de ladite substance:

- .0 : Utilisation aiguë
- .1 : Utilisation nocive pour la santé
- .2 : Syndrome de dépendance
- .3 : Syndrome de sevrage
- .4 : Syndrome de sevrage avec *delirium*
- .5 : Trouble psychotique
- .6 : Syndrome amnésique
- .7 : Trouble résiduel ou psychotique tardif
- .8 : Autres troubles mentaux et du comportement
- .9 : Troubles mentaux ou du comportement, sans précision

Types de consommation

Pour ce qui est de la consommation d'alcool, 15% de la population est abstinente, et 60% n'a pas de problème et n'a qu'un risque faible; pour ce groupe, on fait uniquement de la prévention primaire. Ensuite, 20% des personnes ont des problèmes, potentiels ou réels, et on fait donc des

interventions focalisées. Finalement 5% sont dépendants et ont de sévères problèmes, ce qui nécessite des traitements spécialisés.

Pour le cannabis, ces chiffres sont moins sûrs; on aurait 30% d'usage récréatif dans la population, et 0.8 à 25% de dépendants.

Dans la population, on a 1% de joueurs pathologiques, mais seulement 2% parmi ceux-ci consultent; c'est donc une pathologie silencieuse, qui est difficile à diagnostiquer.

Quelques fondements neurobiologiques

En utilisant le **modèle animal**, on a remarqué que le cerveau est marqué par les drogues. On a un rôle central de la dopamine, qui régule le plaisir naturel et artificiel. De plus, ces problématiques ont la même localisation cérébrale que les émotions (rôle central de l'amygdale, qui est le lieu du fameux « craving »)!

Certains aspects neuro-hormonaux peuvent entraîner une modulation psychosomatique globale, ce qui induit une vulnérabilité augmentée pour les addictions. Les souris sans récepteurs à la cortisone sont incapables de s'autoadministrer une substance psycho-active.

S'il existe effectivement des gènes de vulnérabilité, il faut être exposé au « bon » environnement pour que l'addiction se développe. Finalement, la plasticité neuronale joue un rôle dans le développement de ces pathologies.

Crise suicidaire

En Suisse, on a 19.1 suicides sur 100'000 habitants par année, et c'est la **principale cause de mort violente**, ainsi que la deuxième cause de mortalité chez les 15-20 ans (diminution de 20% de 1992 à 2002). Si les hommes font moins de tentative de suicide, ils utilisent des moyens plus radicaux (50% de pendaison, plus d'utilisation d'arme à feu), et dans toutes les tranches d'âge il y a plus de mort par suicide chez les **hommes**.

L'autopsie psychologique permet de préciser le diagnostic psychiatrique post-mortem en interrogant les proches, les médecins traitants et en consultant les dossiers, et on constate que 90% des patients suicidés présentent une affection psychiatrique. Il est donc important de bien former les médecins de premier recours à détecter les troubles psychiatriques, pour ainsi mieux prévenir les suicides.

Plus de 50% des suicidés ont un **épisode dépressif**, et 4% des patients dépressifs se suicident, plus fréquemment lors du premier épisode. Il faut être vigilant lors du suivi du traitement anti-dépresseur, car il y a un risque d'augmentation transitoire de la suicidalité. 10-15% des patients bipolaires se suicident, et le lithium aurait un effet préventif spécifique.

Aux USA, 70% des suicides des jeunes adultes font intervenir l'**alcool**, qui augmente le risque d'agir suite à des impulsions suicidaires (côté désinhibitoire très dangereux). Le risque suicidaire est de 10% chez les alcoolo-dépendants. C'est donc un facteur qui abaisse le seuil de passage à l'acte et que l'on doit traiter.

Pratiquement 5% des patients **schizophrènes** se suicident, et ce suicide est souvent lié aux symptômes affectifs de la maladie (ce sont rarement des voix qui ordonnent au patient de se suicider). Les facteurs de risque sont la mauvaise compliance au traitement, les abus de substances et les précédentes tentatives de suicide. Dans les **troubles de la personnalité**, on a des patients avec une personnalité émotionnellement labile ou antisociale. L'agressivité à l'égard d'autrui est retournée contre soi; le geste suicidaire vient punir l'autre.

Le contexte de **maladies somatiques graves** augmentent également le risque suicidaire; on peut citer le cancer, certaines maladies infectieuses, les douleurs, les lésions de la moelle, etc. Cela est souvent dû à une douleur trop importante, ou à une stigmatisation de la maladie.

On constate également un important taux de suicide chez la **personne âgée**, notamment lié aux troubles dépressifs, la dépendance à l'alcool, les troubles cognitifs, les affections somatiques, les deuils et la perte d'autonomie.

Une **histoire familiale** de suicide double le risque suicidaire. Les jumeaux monozygotes sont plus touchés que les dizygotes. On a des recherches dans la neurobiologie, notamment dans l'axe de l'altération du système sérotoninergique ou de l'axe hypothalamo-hypophysaire.

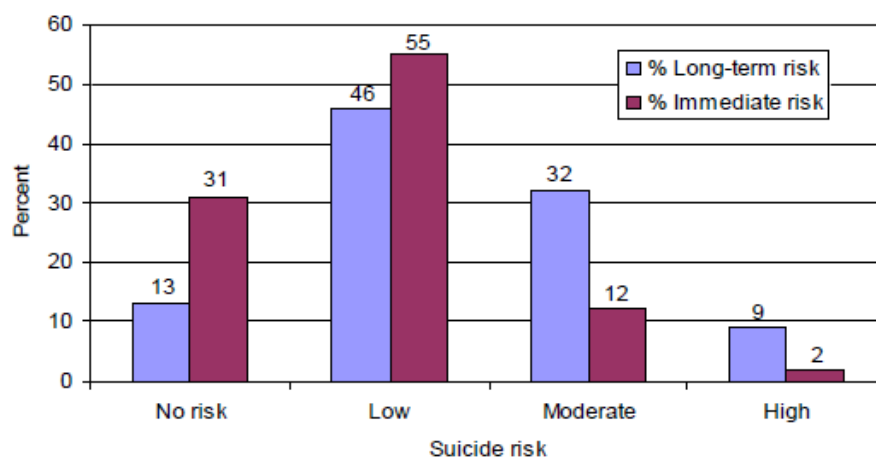
La **prédiction du suicide est difficile**, car les facteurs de risques individuels comptent pour une petite proportion de la variance du risque. Chaque personne dépressive devrait être investiguée pour un risque suicidaire; l'aborder n'augmente pas le risque, mais au contraire le diminue. Cela permet à l'interrogateur de faire se rendre compte au patient que cet état de réduction du champ des possibles est transitoire, et que l'on va trouver des ressources pour y faire face.

La **tentative de suicide TS** est le prédicateur le plus important du suicide (40% des cas), particulièrement chez les personnes âgées, les hommes, les abus de substances, en cas de TS répétées, et de forte intentionnalité suicidaire. On constate 1-6% de suicides dans l'année qui suit une TS.

Le **potentiel suicidaire** s'évalue selon les facteurs de risques, l'urgence (imminence, degré de l'élaboration du scénario) et la dangerosité (létalité et accessibilité des moyens).

Les facteurs de risque « proximaux » sont les précédentes tentatives, les troubles psychiatriques, les troubles somatiques, les crises relationnelles, les crises professionnelles (40% sans emploi), l'isolement (45% vivent seul), l'accès aux moyens, ainsi que l'exposition au suicide (proches, « people »).

Les **mesures concrètes** à prendre si le potentiel suicidaire est élevé est une hospitalisation (volontaire ou PLAFA), ou un suivi ambulatoire rapproché, si le risque paraît moins élevé et qu'une alliance thérapeutique peut se construire avec le patient.



*On constate sur ce graphe que l'estimation du risque suicidaire lors du dernier contact est peu prédictible!
les stratégies de prévention restent tout de même limitées.*

La stratégie globale consiste en le retrait de l'accès à certaines méthodes et en des programmes de prévention ciblés (groupe à risque, prévention scolaire). L'efficacité a été établie dans plusieurs pays.

Traitement médicamenteux

Antipsychotiques

Introduction

Les noyaux thalamiques relaient l'information sensorielle aux réseaux de neurones pyramidaux dans le néocortex et le cortex limbique, et cela par des afférences glutamatergiques. Une réponse excessive des neurones pyramidaux est un probable mécanisme pathophysiologique de la schizophrénie.

Cette hyperstimulation peut être facilitée par les projections des noyaux sous-corticaux; l'activation des récepteurs D1 et D2 augmente la réponse neuronale au glutamate. Ensuite, l'activation des récepteurs 5-HT_{2A} facilite la libération de glutamate. Finalement, l'activation des neurones pyramidaux est modulée par les interneurons GABAergiques avec des projections cholinergiques et noradrénergiques.

Certaines **substances psycho-actives** peuvent entraîner des syndromes psychotiques. La cocaïne est un agoniste dopaminergique, donc entraîner une hyper-excitation des neurones pyramidaux; c'est également un agoniste noradrénergique, qui favorise donc la libération de glutamate.

Le LSD est un agoniste sérotoninergique qui favorise la libération de glutamate, et l'atropine est un anti-cholinergique qui module l'activité des interneurons, ce qui augmente l'excitabilité des neurones pyramidaux.

Les antipsychotiques sont indiqués dans plusieurs pathologies psychiatriques; on peut citer la schizophrénie, les syndromes paranoïdes hallucinatoires, les manies et états maniques, les épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires, ainsi que les états d'agitation psychomotrice. Certaines substances sont antiémétiques, comme le droperidole et le metoclopramide.

Il faut savoir qu'un des mécanismes pour les symptômes psychotiques est l'hyperactivité dopaminergique, avec une augmentation de la concentration de dopamine au niveau de la synapse. Cette dopamine va agir sur les récepteur **D1 ou D2 post-synaptiques**, et tous les anti-psychotiques sont des **antagonistes de ces récepteurs** (peuvent également bloquer la synthèse ou la libération de dopamine en présynaptique)!

Dans le traitement de la schizophrénie par ces antipsychotiques, la posologie, le choix du médicament et la voie d'administration dépendent de plusieurs facteurs:

- Diagnostic et symptomatologie
- Efficacité

- Effets secondaires et sensibilité du patient à ces effets
- Interactions médicamenteuses (métabolisme par CYP450)
- ***Pas de biomarqueurs*** pouvant prédire la réponse au traitement

On a une bonne corrélation entre la dose clinique d'antipsychotique et l'affinité pour le récepteur D2. Tous les antipsychotiques actuellement sur le marché sont des **antagonistes ou agonistes partiels des récepteurs D2!**

Classification

Antipsychotique	Substance pharmacologique	Nom commercial
Typiques <i>Sédatifs</i>	<i>Lévomepromazine</i>	Nozinan®
	Zuclopentixol	Clopixol®
	<i>Haloperidol</i>	Haldol®
	Pimoxol	Orap®
Atypiques	Clozapine	Leponex®
	Rispéridone	Risperdal®
	9-OH rispéridone	Invega®
	Olanzapine	Zyprexa®
	<i>Quetiapine</i>	Seroquel®
	Amisulpiride	Solian®
	Aripiprazole	Abilify®
	Sertindole	Serdolect®
	Lurazidone	Latuda®

Typiques

Dans les antipsychotiques typiques, dits également classiques, on a tout d'abord les typiques « **incisifs** ». Ce sont principalement des antagonistes du récepteurs D2, qui ont pour lui une forte affinité et que l'on utilise donc à petite dose. On a un risque d'effets pyramidaux. Si ces médicaments ont une bonne efficacité sur les symptômes positifs, ils sont peu efficaces pour les symptômes négatifs.

Ensuite, on a l'autre catégorie des antipsychotiques classiques « **sédatifs** ». Habituellement, on les donne à haute dose; ce sont des antagonistes des récepteurs D2, mais ***également d'autres récepteurs***, notamment histaminergiques H1, cholinergiques et adrénergiques. Ces médicaments

sont utiles pour la sédation, et sont utilisés parfois en association avec un incisifs, chez les patients vraiment agités.

Les **effets indésirables** fréquents des sédatifs sont une **sédation** via H1 (mais peut être l'effet recherché!), une action anti-cholinergique (déficit de l'accommodation, constipation, rétention urinaire), une action anti-adrénargique (hypotension orthostatique) et un effet métabolique de prise de poids via entre autre H1, ainsi qu'une hyperglycémie.

Ensuite, on a des effets indésirables fréquents qui sont associés aux incisifs et aux sédatifs, donc à tous les anti-psychotiques typiques. On peut citer tout d'abord une **hyperprolactinémie**¹(aménorrhée, gynécomastie, galactorrhée), ainsi que des **effets extrapyramidaux**. En effet, on a fréquemment un parkinsonisme (10% des patients), et on peut constater des dyskinésies tardives (affecte beaucoup la sphère bucolinguale) après le traitement prolongé, qui peuvent persister même après l'arrêt du traitement. On remarque également parfois une dystonie ou une acathisie (ne tient plus en place).

Normalement, la dopamine bloque la libération d'Ach à partir des neurones cholinergiques post-synaptiques au niveau de la voie nigrostriée (connexions entre neurones dopaminergiques et cholinergiques). Ainsi, si on donne un antagoniste dopaminergique comme l'est l'antipsychotique, on a trop d'Ach, ce qui entraîne les mouvements anormaux. Ceux-ci sont moins fréquents avec les antipsychotiques avec une activation anticholinergique comme la clozapine ou l'olanzapine. Sinon, on administre des **anticholinergiques** pour traiter ce syndrome extrapyramidal.

On a finalement un effet indésirable plus rare, qui a une fréquence plus élevée parmi les typiques que les atypiques. Le **syndrome malin des neuroleptiques** est caractérisé par une hyperthermie, une rigidité musculaire, des troubles neurovégétatifs et une altération de l'état de conscience; il peut conduire à un décès dans 10% des cas.

Les neuroleptiques classiques ont un effet insuffisant sur les symptômes négatifs et cognitifs, et des effets secondaires extra-pyramidaux, cardiovasculaires (prolongation du QT), hyperprolactinémiques et cognitifs.

Atypiques

Ce sont tous des antagonistes D2 (sauf aripiprazole, qui est un agoniste partiel), ainsi que des antagonistes 5HT2A (sauf amisulpride, action en présynaptique sur D2/D3), cette dernière caractéristique ne faisant qu'augmenter l'activité anti-psychotique. On a une meilleure efficacité, cependant toujours modérée, contre les symptômes négatifs, et une incidence diminuée d'effet

¹ La dopamine est un antagoniste de la prolactine!

extrapyramidaux et d'hyperprolactinémie (médicament et dose dépendant). Ils sont donc un **premier choix de prescription**.

On constate, avec la **clozapine** qui est le prototype (nombreux mécanismes d'action, donc plus efficace mais avec beaucoup d'effets secondaires), de plus une efficacité chez des patients résistants aux antipsychotiques. Globalement, ils sont **plus à risque de prise de poids** que les typiques.

On a évidemment plusieurs **effets indésirables**. La clozapine entraîne en effet une somnolence, une hypotension, un effet antimuscarinique, des troubles métaboliques avec une importante prise de poids et une hyperglycémie, et finalement une hyperlipidémie. Dans 1-2% des cas, on peut avoir une toxicité qui entraîne une **agranulocytose**; des contrôles hématologiques sont donc obligatoires.

L'olanzapine n'entraîne pas d'agranulocytose, mais les mêmes autres effets secondaires; elle est malheureusement moins efficace que la clozapine. La **rispéridone** entraîne une hypotension, une vision trouble, des troubles de concentration, ainsi qu'une prise de poids, bien que moins importante que dans les cas ci-dessus.

Finalement, l'amisulpride a des effets secondaires extrapyramidaux et peut entraîner une hyperprolactinémie, ainsi que des troubles métaboliques avec une légère prise de poids.

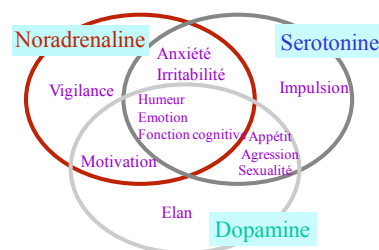
La **marge thérapeutique se situe entre 60 et 80% de l'occupation des récepteurs D2**; au-delà, on constate une forte augmentation des effets secondaires extrapyramidaux.

Antidépresseurs

Introduction

Ces médicaments sont par exemple indiqués dans la dépression, les troubles anxieux, les troubles paniques ainsi que les TOC. Les principes sont une augmentation de la neurotransmission monoaminergique (NA, 5-HT), et une apparition de l'**effet antidépresseur après 2 semaines environ**. Il faut donc être attentif aux tendances suicidaires dans les premières semaines, surtout avec les tricycliques qui sont très toxiques en surdosage.

Lors d'un traitement par antidépresseur sérotoninergique, on bloque le transporteur, ce qui augmente la concentration de sérotonine synaptique. Cela entraîne une activation du récepteur pré-synaptique par cette sérotonine, ce qui diminue sa libération; on a donc à court terme une diminution des concentrations de sérotonine. Cependant, après deux semaines, on a une **down-regulation de ces récepteurs pré-synaptiques**, avec une augmentation de la libération des monoamines.



Il y a donc plusieurs cibles pharmacologiques des antidépresseurs:

1. **Synthèse**: on administre un précurseur de la sérotonine, comme le tryptophane.
2. **Antagonisme récepteur 5HT₂**: on peut citer le trazodone ou la mirtazapine
3. **Inhibiteurs de la recapture**: de la sérotonine (SSRI => fluoxétine), ou de la NA et de la sérotonine (tricycliques => amitriptyline, SNRI => venlafaxine).
4. **Dégradation**: inhibiteurs de la mono-amine oxydase MAO (moclobemide)

Le **système 5-HT** est impliqué dans la dépression. Premièrement, on retrouve dans le LCR des patients déprimés un produit de dégradation de la sérotonine, 5-HIAA. Ensuite, on a une diminution de liaison au récepteur de la sérotonine dans les plaquettes et tissus post-mortem. Puis, les anti-dépresseurs augmentent le 5-HT intrasynaptique, et finalement lorsque l'on a une déplétion du précurseur de la sérotonine on constate une rechute chez les patients traités. Cependant, il est évident que la sérotonine n'explique pas tout.

Le traitement antidépresseur va finalement augmenter le **BDNF**, qui est le messageur final, ce qui va entraîner une augmentation de l'action trophique, de la survie des neurones et de leur fonction. Ce BDNF est impliqué dans la **plasticité neuronale**, et l'hypothèse est que dans la dépression, on a une down-régulation de ce facteur (diminué dans le sérum des patients déprimés), et donc une perte des connexions synaptiques, qui devraient être rétablie par le traitement.

On constate une augmentation de l'activité cérébrale dans le cortex frontal médian, cingulaire subgénéral et dans l'amygdale au cours de la dépression.

Classification

Tricycliques

On peut citer l'imipramine (Tofranil®), l'**amitriptyline** (Saroten®) et la clomipramine (Anafranil®). Leur mécanisme est une **inhibition de la recapture des monoamines** NA et 5-HT, une interaction avec plusieurs récepteurs (muscariniques, α_1 -adrénergiques, histaminiques) et des interactions autres, notamment avec des canaux sodiques.

Les **effets indésirables** sont des effets anti-muscariniques (sécheresse buccale, rétention urinaire, augmentation de la pression intra-oculaire, confusion mentale), anti-histaminergiques (sédation), anti- α -adrénergiques (hypotension orthostatique), des arythmies graves avec des bloc AV à cause de l'interaction avec les canaux sodiques, une prise de poids et des dysfonctions sexuelles.

La toxicité aiguë, également appelée **tentamen**, est caractérisée par une excitation, des convulsions, une dépression respiratoire, un coma et des arythmies.

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine SSRI

Tous sont génériques, mais on peut mentionner les substances de base, comme la fluoxétine (Fluctine®), la paroxétine (Deroxat®), la *Sertraline* (Zoloft®), le *Citalopram* (Seropram®) et la Fluvoxamine (Floxyfral®). Ils ont moins d'effets indésirables que les tricycliques, et éventuellement moins de toxicité aiguë et donc de risques associés au suicide.

Les effets secondaires sont l'anxiété, l'insomnie, les céphalées, les troubles sexuels, les nausées, les diarrhées, la perte d'appétit et le **syndrome de discontinuation sérotoninergique**. Dans ce dernier, on constate une irritabilité, des nausées, une sensation de chocs électriques, des insomnies, ainsi que des sueurs profuses. Ces substances inhibaient également les enzymes du P450.

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline SNRI

On peut citer la duloxétine et la *venlafaxine*. Ils ont un profil d'affinité pour l'inhibition de la recapture de la sérotonine identique aux tricycliques, mais avec une affinité plus faible pour les récepteurs muscariniques, H1 et adrénergiques. Ainsi, ils ont logiquement **moins d'effets indésirables potentiels**!

Pour ces effets indésirables, ils ont un profil similaire aux SSRI pour les effets sérotoninergiques comme les troubles gastro-intestinaux, et aux tricycliques pour les effets noradrénergiques comme l'hypertension orthostatique.

Antidépresseurs sérotoninergiques et noradrénergiques

On cite la *mirtazapine*. On n'a pas de blocage de transporteurs, mais une **stimulation de la libération de sérotonine** et un effet noradrénergique. Il y a un effet H1 sédatif, ainsi qu'une prise de poids. On ne constate que peu ou pas d'effet GI et sexuels.

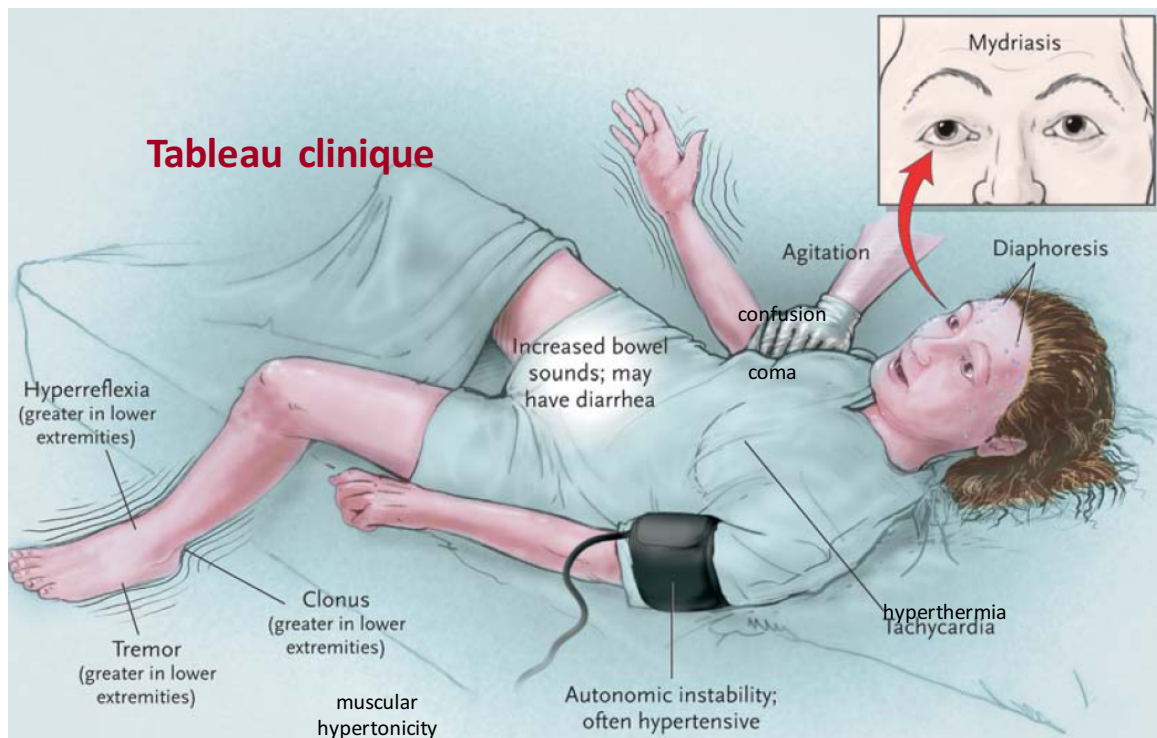
Inhibiteurs des MAO

On peut citer le *moclobémide* (Aurorix®), qui est un inhibiteur compétitif et sélectif de MAO, qui va donc augmenter les niveaux des mono-amines dans le SNC. Ces IMAO augmentent les effets des amines sympathomimétiques (tyramine, amphétamine). La tyramine alimentaire est dégradée par la MAO de l'intestin et du foie, et elle s'accumule dans les terminaisons sympathiques, ce qui augmente la libération d'adrénaline et de NA.

En clinique, on les utilise dans la dépression, pas en première intention mais chez les patients qui ne répondent pas aux autres antidépresseurs.

Les effets indésirables sont une excitation de SNC (insomnie, tremblement, convulsions), une hépatotoxicité, des crises hypertensives, un risque d'interaction avec les aliments riches en

tyramine, ainsi qu'un risque de **syndrome sérotoninergique** (représenté ci-dessous) fortement augmenté lorsqu'il est associé avec des antidépresseurs sérotoninergique ou sérotoninergique/dopaminergique; c'est une contreindication, et il faut également être très prudent lorsque l'on passe d'un traitement à l'autre (!demi-vie!).



Lithium

Le mécanisme d'action du ***lithium*** est une inhibition du métabolisme des pospho-inositides, qui est probablement liée à l'effet anti-maniaque/antidépresseur. Il n'est pas classé comme antidépresseur, mais comme **stabilisateur de l'humeur**. Il est utilisé dans le traitement des phases aiguës et en prophylaxie à long terme de la maladie maniaco-dépressive, et il peut augmenter l'effet antidépresseur.

Comme la **marge thérapeutique est étroite**, le dosage sanguin est obligatoire. Comme effets indésirables, on peut constater des tremblements, des nausées, des diarrhées, de la fatigue, un diabète insipide rénal, ainsi qu'une rétention sodée et des oedèmes. Plus rarement, on peut observer une toxicité rénale, des arythmie et une intoxication (vomissement, diarrhée, tremblement, ataxie, coma, convulsion).

Efficacité

Globalement, tous les antidépresseurs sont égaux en terme d'efficacité, mais il y a quand même des différences. Le choix est notamment basé sur le profil d'effets secondaires, le profil du potentiel d'interaction métabolique et l'habitude du prescripteur.

Notamment, pour les tricycliques on a notamment une problématique due au fait que les doses efficaces sont supérieures aux doses initiales, et souvent aussi supérieures aux doses utilisées. Il

est important d'évaluer l'utilité d'un traitement anti-dépresseur au cas par cas; on prescrit pour les dépression d'intensité moyenne à sévère, mais en cas de dépression légère.

Si l'on résume les conclusions d'une méta-analyse des antidépresseur, on constate que **la sertraline, le citalopram, la venlafaxine et la mirtazapine** semblent les plus efficaces; de plus, ils ont un faible potentiel d'interaction avec les CYP450. Cependant, ces résultats ne sont pas gravés dans le marbre. On a des différences modérées, mais à défaut de mieux ces résultats peuvent être utilisés comme une première indication.

La dépression se traite au minimum 6 mois à dose adéquate; les 6 mois sont à compter à partir de la rémission, et non après le début du traitement. la dépression récurrente à 2-5 ans se traite généralement à la même dose que la phase aiguë.

Pour ce qui est de la schizophrénie, on continue le traitement jusqu'à 1 ans après une rémission complète d'un premier épisode aigu, 2 ans après la rémission d'un deuxième épisode aigu. En cas de diagnostic de schizophrénie avec des épices multiples et des symptômes résiduels, on instaure un traitement à très long terme.

Ainsi, on constate qu'en psychiatrie, on utilise des traitements à long terme!

Psychothérapie

Introduction

On entend par psychothérapie une forme de traitement qui concerne des maladies psychiques et psychosomatiques, qui se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologie. La psychothérapie n'est pas une cause au sens médical, mais est un ***principe qui permet d'établir une relation thérapeutique***; une école de psychothérapie n'est pas plus scientifique qu'une autre. C'est donc une **théorie narrative**, et non une théorie étiologique.

Elle vise un objectif thérapeutique défini, et repose essentiellement sur la communication verbale, sans exclure les traitements médicamenteux de soutien. Elle se caractérise par des séances de thérapie régulières et planifiées ainsi qu'un rapport de travail de confiance, et elle comprend une relation thérapeutique suivie et une réflexion systématique. La psychothérapie **nécessite une adhésion explicite**, sinon elle ne sert à rien.

Le psychothérapeute pratique cette activité à titre **professionnel** (en Suisse, il est possible d'avoir la double formation, de psychiatre et de psychothérapeute), et le traitement est proposé à des patients qui se plaignent d'un mal-être et qui décident d'entreprendre une démarche pour le soulager. On peut la pratiquer sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.

	Psychiatrie	Psychothérapie
Expérience cliniques	5 ans	
Théorie	330 h.	270 h.
Pratique psychothérapique		300 h. 3-10 cas
Supervisions	150 h.	150 h.
Expérience personnelle		80 h.

Le psychothérapeute propose une situation psychothérapique de son choix, qu'il estime utile par les moyens psychologiques qu'elle met en jeu. Ce travail s'exécute dans le cadre d'un contrat définissant les engagements de chacun et les limites de leur action commune.

Les psychothérapies sont nées au **début du XIX^e siècle**. Jusque là, on considérait les troubles psychiatriques comme une altération de l'intelligence, et pour cela il fallait avoir des idées délirantes. Puis, les psychiatres ont commencé à interroger la souffrance psychique des patients psychiatriques, et on a constaté que ***l'humeur pouvait être pathologique***, et que ces troubles pouvaient également être graves, sans idée délirante.

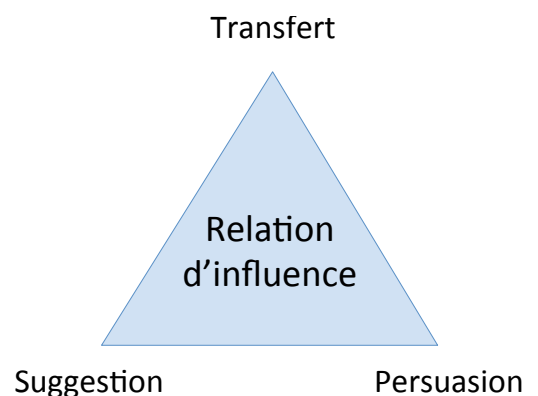
On remarque que discuter avec des patients peut avoir des effets positifs sur la pathologie; la posture bienveillante du médecin à l'égard de son patient est bénéfique. Cela, et la communication, est utile lorsque l'on a une relation significative avec le patient, ce qui permet d'avoir un impact sur le trouble psychique.

Les psychothérapies à proprement parler naissent à la fin du XIX^e, qui est liée à la question de l'hystérie et celle de l'hypnose. On a un débat entre Charcot et Bernheim. Le premier démontre que l'hypnose peut influencer les troubles fonctionnels des hystériques, donc fait de la suggestibilité de l'hystérie un symptôme. Le second fait de **l'hypnose un moyen thérapeutique**, et c'est lui qui va l'emporter, car l'hypnose devient la première méthode psychothérapeutique reconnue à partir de 1892.

La deuxième racine de la psychothérapie est Paul Dubois, qui pense que la suggestion soulève un problème éthique, car on met le patient dans un état de dépendance par rapport à son thérapeute, ce qui est discutable. Lui propose un ***débat intellectuel***, où il essaie de convaincre le patient des erreurs de jugement en rapport avec ses troubles. Il est donc l'ancêtre des thérapies comportementales et cognitives.

Le troisième pilier est Freud, qui s'interroge sur le bienfait de ce genre de pratique lors d'une discussion avec le patient. De plus, il met en évidence que le patient a tendance à déformer la relation thérapeutique; il postule que ces déformations sont l'expression des troubles psychiques dans la relation. Ces déformations, appelées **transfert**, deviennent donc l'objet du travail avec le patient.

A la fin du XIX^e, on a déjà un aperçu de ce qu'est la psychothérapie aujourd'hui. Ces trois courants ont en commun le fait que les troubles psychiatriques sont des phénomènes psychiques, qu'il est ***essentiel de nouer une relation thérapeutique***, que cette relation est spécifiquement basée sur la parole, que la participation active du sujet au traitement est requise, ainsi que la psychothérapie comporte une exigence de vérité à l'égard de soi-même.



Ce qui pose problème, c'est que la psychanalyse, plus que le système d'idées qu'elle était au départ, est devenue une idéologie, et que ce côté plus rigide a été beaucoup critiqué, ce qui a entraîné de très violents débats et contestations. La psychanalyse comme explication unique du monde est très exagérée, alors que le système d'idée en soi permet très bien de traiter certains patients.

Types

Le fait que les psychothérapies soient des manières de raconter des histoires explique pourquoi il y a autant d'écoles différentes; c'est une richesse, car les patients peuvent choisir ce qui leur convient.

En Suisse, on reconnaît 3 grandes écoles: psychanalytiques, cognitives et comportementales, et systématiques. La psychothérapie est plus large, car elle reconnaît deux autres écoles: humanistes et intégratives.

Psychothérapies psychanalytiques

La théorie n'est pas nécessairement ce qui nous intéresse, mais plutôt le **style de relation avec le patient**; c'est cela qui permet d'orienter au patient vers les différentes thérapies possibles, en fonction de son caractère.

Elles tentent de mettre en évidence des **conflits intrapsychiques**. On considère que ces derniers sont à l'origine des **symptômes, qui sont une manière d'obtenir des compromis entre ces désirs contradictoires**. On considère qu'à partir du moment où le patient prend conscience de ce conflit, il en est moins dépendant, et il peut l'affronter et non l'exprimer par les symptômes.

La manière de faire face à cela consiste à laisser au patient un espace de parole, en lui accordant une attention flottante et une **neutralité bienveillante**. Le psychothérapeute a pour objectifs de repérer les conflits intra-psychiques, et pour cela il ne faut pas être trop pris dans la relation. Il faut surtout éviter de prendre partie dans les dilemmes proposés par le patient. Le rôle du thérapeute est de reformuler ces conflits, pour permettre au patient de les résoudre.

La seule consigne consiste à dire au patient de partager ce qui le préoccupe (si peu bavard, ce n'est pas pour lui!). On demande au patient de ne pas prendre de décision importante sans en parler avant.

Psychothérapies cognitives et comportementales

Il y a des sortes d'**idées que le patient généralise**, ce qui va faire qu'il développe des symptômes. Les buts de la thérapie est de mettre en évidence ces distortions, dans les cognitions, les émotions et le comportement. La durée des séances est plus longue, mais la durée est limitée, même s'il en faut plusieurs.

La grosse différence se trouve dans la technique du thérapeute; ici, il est **extrêmement actif**, il prend le rôle d'un expert dans ces idées, alors que dans la psychanalyse c'est le patient qui est considéré comme l'expert. Ensuite, le thérapeute utilise des techniques actives (exercices pratiques) pour permettre au patient de modifier son comportement.

Psychothérapies systémiques

Ce que ces thérapies ont de particulier, c'est qu'elles font l'**impasse sur la manière de raisonner du patient** (psychopathologie), mais s'intéresse au modèle de communication dans lesquels le

patient est pris (manière de communiquer). Les symptômes sont le **signe d'une communication dysfonctionnelle**. Cette approche est beaucoup plus déculpabilisante et déstigmatisante.

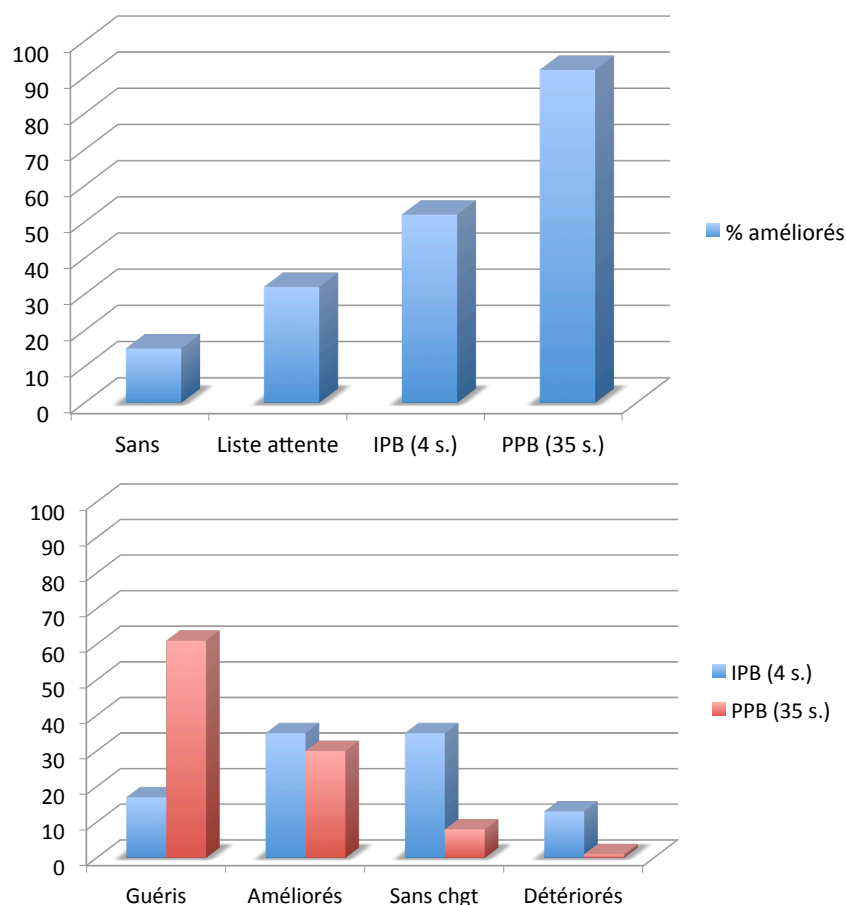
Le but du traitement est de dépister ces structures de communication dysfonctionnelle; pour cela, les thérapeutes sont attentifs à la manière dont le patient communique avec eux. Ils requièrent pour cela volontiers à un observateur externe derrière une glace sans tain, qui peut intervenir. Les séances sont très longues, et peuvent être renégociées à la fin de chaque séance (dans les deux autres psychothérapie, les séances se négocient sous forme de contrat).

Les thérapeutes sont actifs sur la communication, ils vont donner la parole aux membres de l'entourage, faire des jeux de rôle, recourir à des paradoxes, et utiliser des métaphores. Ils essaient donc de modifier la communication de manière active.

Efficacité

L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Ces prestations doivent être efficaces, appropriés, économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. La loi prévoit un contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations.

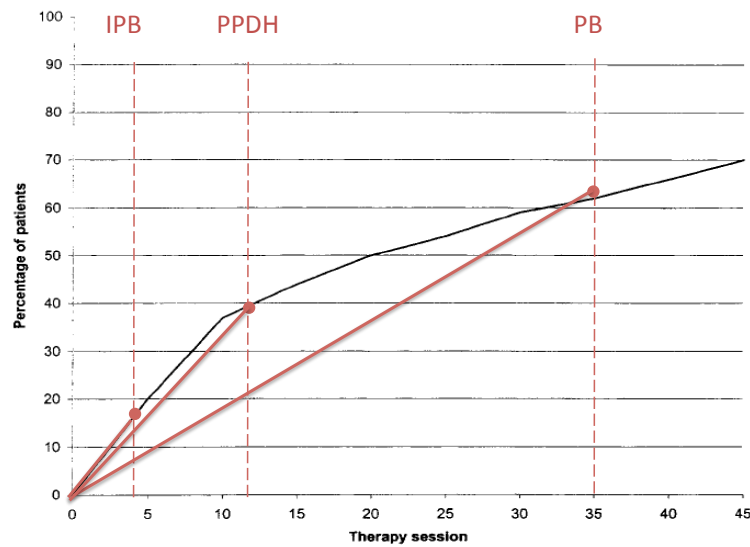
Les psychothérapies ont une amplitude d'effet qui est assez conséquente. Prescrire une psychothérapie n'est pas anodin, car un patient peut aller plus mal après.



On ne constate pas de différences d'efficacité entre les différentes écoles; la progression du patient se fait de manière linéaire.

Beaucoup de patients vont mieux après relativement peu de séances, mais certains ont besoin de beaucoup plus. On n'a ***pas encore trouvé d'indicateurs cliniques*** qui permettent de savoir si le patient a besoin de peu ou de beaucoup de séances; c'est pourquoi on ne limite pas le nombre d'entretiens, ou on fait des séquences de séances.

La courbe dose-effet

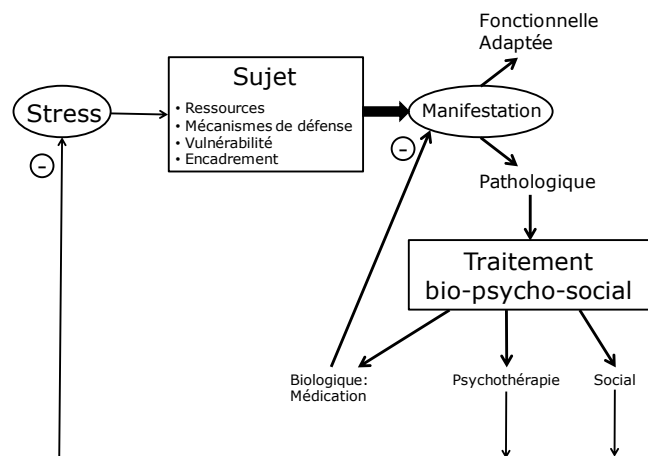


On a un **effet d'incubation**; le patient continue à aller mieux, même après la fin de la psychothérapie.

Autres approches thérapeutiques

Concept de base

Tout sujet dispose d'un certain nombre de ressources et de mécanismes de défense, mais possède également une certaine vulnérabilité et un encadrement qui dépend de l'environnement de chacun. Il suffit parfois de peu, d'un événement particulier, pour déclencher des manifestations. Le traitement biologique permet d'atténuer les manifestations, mais ne résout pas le problème; c'est plutôt le rôle de l'aspect psychothérapeutique et social du traitement.



La prise en charge des troubles psychiatriques graves repose sur le modèle dit « **bio-psycho-social** », c'est-à-dire sur la mise en oeuvre coordonnée de moyens biologiques (essentiellement les médicaments, mais également électrochoc, stimulation transcrânienne), psychothérapeutiques et de mesures sociales.

Lieux de soin

Avant, on avait le **modèle asilaire**; tous les patients convergeaient vers un seul lieu, par soucis de cohérence, et pour mettre les gens à l'abri. Cependant, on avait aussi un mauvais côté, qui a été mis en évidence à la fin des années 60. On a en effet une **stigmatisation**, une exclusion sociale, une induction de la chronicité, et même parfois de mauvais traitements.

L'asile est donc remplacé par un **vaste réseau de structures de soins dans la communauté**, avec de multiples interactions entre les différents intervenants du système. La prise en charge des pathologies lourdes se fait souvent dans divers lieux:

Hôpital: les traitements hospitaliers tendent de plus en plus à être brefs et à ne traiter que les aspects aigus, ce qui suppose un renforcement des autres lieux de prise en charge.

Structures intermédiaires: on peut citer des hôpitaux de jour, des ateliers occupationnels, ainsi que des foyers, des EMS ou des appartements protégés.

Structures ambulatoires: cela peut être l'apanage des psychiatres installés en privé, ou des médecins généralistes. On a également à disposition des institutions de psychiatrie publique, celles-ci étant souvent mieux à même de prendre en charge des situations lourdes qui requièrent l'intervention d'infirmiers ou d'assistants sociaux. On a une intensification de la collaboration entre les médecins privés et les institutions publiques.

Psychiatrie communautaire: ce type de soins, où les intervenants se déplacent par exemple au domicile des patients, se développe de plus en plus. On a mis en place une collaboration avec des institutions existantes, et développé des modes spécifiques d'intervention. La notion de réseau est très importante.

Coordination des soins

La chronicité qui caractérise souvent les troubles psychiatriques rend nécessaire la coordination de diverses formes d'intervention thérapeutique ou d'encadrement. Cette collaboration nécessite donc un travail **en équipe** (collaboration pluridisciplinaire à l'intérieur de l'institution de soins) et **en réseau** (collaboration avec des intervenants externes à l'institution).

Les partenaires fréquents de réseau sont les médecins généralistes, les CMS, les EMS, les éducateurs, le personnel d'ateliers protégés, les employeurs, les organes de l'AI, la justice de paix, les offices de tutelles, la police, la justice pénale, les associations d'usagers ou de proches, ainsi que les familles et les représentants thérapeutiques.

La psychiatrie est un **monde en mouvement**. Les modifications en cours dans la prise en charge publique des troubles psychiatriques chroniques sont une **diminution marquée de la durée des séjours hospitaliers**, un rôle accru des réseaux de soins communautaires, ainsi que de façon générale une accentuation du côté « soin » au détriment du côté « contrôle social ». Ces modifications suscitent de nombreux débats parmi les acteurs engagés, et ne sont de loin pas encore bien maîtrisées.

Traitement non-volontaire

La plupart des traitements en psychiatrie sont suivis volontairement par les patients. Il y a cependant un certain nombre de situations où la **prise en charge se fait sous contrainte**; la relation médecin-malade en est modifiée, et cette modification doit être abordée clairement avec le patient.

Dans les prises en charge imposées, on distingue la privation de liberté à des fins d'assistance **PLAFA** (médical ou justice de paix), qui est régie par le Code Civil et est une décision de la Justice

de paix, des **traitements imposés par la Justice pénale**, qui sont des mesures décrites dans le Code Pénal, en complément ou en substitution de la peine.

Le **PLAFA médical** peut être ordonné par les médecins de premier recours (généralistes, internistes, psychiatres, pédiatres, garde d'urgence). La décision peut aussi être prise par le médecin délégué (nommé par le médecin cantonal), qui est une personne par laquelle on passe si on ne fait pas partie des médecins de premier recours. Cette décision est basée sur la notion de risque imminent pour lui-même ou les autres, ou pour dégradation grave de la situation.

La durée maximale est de **6 semaines**. Avant ces 6 semaines, le médecin responsable du lieu de soin peut demander la prolongation pour des raisons psychiatriques, sinon la mesure doit être levée à 6 semaines (peut être transformée en admission volontaire). Le patient peut s'opposer à la mesure en écrivant au Juge de paix dans les 10 jours, qui doit prendre une décision dans les 5 jours sur base d'expertise.

La loi sur la santé publique dans le Canton de Vaud a introduit des nouveautés importantes pour la psychiatrie: les directives anticipées, le rôle du représentant thérapeutique, et également depuis 2013 le traitement ordonné dans la communauté.

Recherche translationnelle en psychiatrie

Aujourd'hui, la dichotomie entre réductionnisme biologique et chapelles psychothérapeutique est dépassée. Beaucoup de troubles psychiatriques se comprennent comme le fruit de l'interaction entre la vulnérabilité constructive (à base biologique ou psychologique) et les facteurs de stress (psychologiques, biologiques ou sociaux).

Il est donc important de **renforcer la collaboration entre cliniciens et chercheurs en neurosciences fondamentales** de manière à promouvoir une meilleure connaissance des mécanismes qui sous-tendent les maladies psychiatriques, des classifications qui reposent sur des bases plus solides, ainsi que la découverte de traitements plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des patients.

Il y a donc quelques **limitations en psychiatrie clinique contemporaine**, avec deux problèmes centraux. Premièrement, on ne connaît pas quels sont les mécanismes biologiques dans la très grande majorité des troubles, et de plus les classifications des maladies psychiatriques sont basées sur la seule observation clinique de par l'absence de marqueurs biologiques.

On a donc une impossibilité de définir des stratégies de soins biologiques visant à remédier à la cause du trouble, et on regroupe des pathologies potentiellement très différentes en termes biologiques sous un même label syndromique. De plus, on ne peut pas proposer des traitements

différenciés selon la phase de la maladie, ni mesurer l'évolution du trouble et la réponse au traitement biologique.

Actuellement en psychiatrie, la quasi totalité des traitements biologiques utilisés sont issus de la **sérendipité**, donc d'une observation par hasard d'un effet. Il existe plusieurs modèles explicatifs des troubles psychiatriques qui ont été construits qu'à postériori, sur la base de ces observations (théorie de l'excès de dopamine dans la psychose).

De plus, l'**identification des troubles** n'est pas vraiment claire et précise; on regroupe des troubles en syndromes souvent peu satisfaisants (schizophrénie), on constate une délimitation floue entre les pathologies, et finalement on est incapable d'identifier précocement les troubles de manière précise (par exemple, 80% de faux positifs dans les critères de prodrome psychotique).

L'objectif est de faire **converger recherche clinique et neurosciences de base**. On peut citer l'exemple des psychoses émergentes, domaine qui tend à passer de la clinique à la recherche translationnelle, en identifiant des marqueurs; c'est dans ce type de contexte qu'il est important de faire converger les deux aspects ci-dessus

Comme exemple de **projet translationnel**, on peut évoquer l'apport des neurosciences à l'intervention précoce dans les troubles psychotiques. Le déficit en glutathion pourrait être un facteur de risque pour la schizophrénie, et c'est sur cela que se centre cette recherche.

La **recherche sur des cohortes cliniques** permet d'identifier des problématiques cliniquement pertinentes, de développer des approches adaptées aux besoins des patients et d'évaluer l'impact de ces traitements innovants.

Les **approches neurobiologiques** permettent d'explorer les mécanismes impliqués dans la maladie, l'identification de marqueurs des divers stades et des diverses formes de troubles psychotiques, ainsi que le développement de nouvelles formes de traitements médicamenteux. La **recherche translationnelle** crée un contexte dans lequel compétences cliniques et neuroscientifiques peuvent entrer en synergie, et est l'une des stratégies essentielles pour améliorer les traitements en psychiatrie contemporaine.